



复旦大学生命科学学院

School of Life Sciences Fudan University

课程自用讲义

医学人类学

2026 春

本讲义采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0) 发布。您可以自由复制、学习和分发本作品，但必须注明作者姓名，且不得用于商业目的，也不得对本作品进行任何修改或改编。协议全文见：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

《医学人类学》是复旦大学本科跨学科微专业（即 Minor 学位）医学人类学的必修课程，不包含在生命科学学院生物科学的培养方案之内。

制作：复旦 23 生科系 若许_lysis

目 录

I 第一章 总论 1

1 医学人类学的五大发展路径 1

2 医学人类学的四个共识 2

3 生物文化主义 (Bioculturalism) 3

4 目前医学人类学的一些热门领域 3

II 第二章 文化、文化能力与生物医学 3

5 人类学可以贡献什么? 4

6 人类学的研究对象：文化 5

6.1 文化 101 5

6.1.1 文化的定义 5

6.1.2 文化的特点 5

6.2 生物医学中文化的重要性 6

6.3 当代健康问题下的潜在文化动态 7

6.3.1 张雪峰去世事件 7

6.4 生物医学在社会生活中的渗透 8

6.4.1 医疗的三大文化功能 8

6.5 文化分析（不考） 8

6.5.1 文化分析的作用 9

6.6	讨论：巴勒斯坦的第一部动画《Fatenah》(2009)	9
6.6.1	讨论	9
7	对所谓“文化”之批判	10
7.1	文化是否存在	10
7.1.1	保护文化行动	10
7.2	所谓文化能力（这并非人类学的文化！非常重要！）	12
7.2.1	动人的故事和一个悲剧	13
7.2.2	殡仪馆	14
7.3	讨论 I	15
7.3.1	在自然主义中重要的命题有哪几个，如何理解，在生物医学中的表现有哪些	15
7.3.2	在个人主义中重要的命题有几个，如何理解	16
7.3.3	讨论实录总结	17
7.3.4	补阙	18
7.4	讨论 II	19
7.4.1	作者认为对于医学院学生来讲，学习医学的过程是怎样的	19
7.4.2	作者是通过医学院培养的哪些关键环节来理解医学院学生的现实世界的	20
7.4.3	作者在这篇文章中的主要的理论对话对象是谁？她与该对象都有哪些分歧？	20
7.4.4	讨论实录总结	21
III	第三章 疾痛叙事	22
8	健康与疾病	22
8.1	疾病	22

8.1.1	疾病 (Disease) 与病痛 (illness) 的区别	23
8.1.2	不同文化对疾病的理解	23
8.2	治疗 (Cure)	24
8.2.1	安慰剂效应	24
8.3	病痛个人传记 (The illness Autobiography)	24
8.4	人类学中的病痛叙事	25
8.4.1	病痛叙事的理论流派与代表人物	26
8.4.2	社会苦痛 (Social Suffering)	26
8.4.3	早期对“叙事”的理解	27
8.4.4	病痛叙事的改变与发展	27
8.5	在临床医学上的病痛叙事	28
8.5.1	思考题	29
8.6	讨论: 记录电影《Unrest》, “无法安睡”	29
8.6.1	讨论	29
 IV 第四章 病痛的社会建构		30
 9 总述: 社会建构论		30
9.1	社会建构论在医学人类学语境中提出的必要性	30
9.2	疾病社会建构理论的三大主题	30
9.2.1	疾病社会建构的理论根源	31
9.3	社会建构论的理论谱系	31
9.3.1	理论谱系 I	31
9.3.2	理论谱系 II	32
9.3.3	理论谱系 III	32

9.3.4	理论谱系 IV	32
9.4	社会建构的主要发现	33
9.4.1	疾病的文化意义	33
9.4.2	疾病体验的社会建构	33
9.4.3	医学知识的社会建构	34
9.4.4	社会建构论的社会影响	34
9.4.5	社会建构论带来的转变	34
9.4.6	未来的研究方向?	35
V	第五章 医疗化	35
10	医疗化与现代化	35
10.1	医疗化概念的提出	35
10.2	医疗化的历史	35
10.3	医疗化的历史	36
10.3.1	人体解剖为基础的病理学的确立，取代了以往的体液-环境学说	36
10.3.2	分化的实践	36
10.4	医疗化的批判	37
10.4.1	Ivan Illich, Medical Nemesis(1976)	37
10.5	女权主义的批判	37
10.6	医疗化的新变化	37
11	医疗化的身份、状况与健康	38
11.1	被医疗化的身份 (Medical Identity)	38
11.2	被医疗化的状况与现象	38

12 健康的医疗化	39
12.1 风险作为个人治理的手段	39
12.1.1 基因化	40
12.2 衰老的生物医疗化 (Sharon Kaufman)	40
12.2.1 有关衰老理解的变化	40
12.2.2 对医疗干预说不的可能性	41
12.2.3 未来的照护?	41
13 研究医疗化的思路	42
13.1 讨论: 药瘾《Take Your Pills》	42
13.1.1 结合医疗化的概念, 谈谈对药物问题的看法	42
13.1.2 影片中美国社会中被医疗化的是?	42
13.1.3 现实生活中被医疗化的例子; 新的疾病和新的不正常	43
13.1.4 不同社会阶层的医疗化经历是否相同?	43
VI 第六章 身体, 与不同医学传统中的身体	43
14 总论	43
14.1 为什么要研究身体	43
14.1.1 日常生活中, 什么时候会意识到自己有一个身体?	44
14.1.2 中国的体育身体	44
14.2 社会科学中关于身体的三个共识	44
15 身体的不同文化解释	45
15.1 中国有关身体的三个传统知识体系	45
15.2 从中西文化看身体之谜	45
15.2.1 从两个脉的区别看中西医对触觉的定义	45

15.2.2 从解剖学与肌肉看中西医对视觉的定义	46
15.2.3 从耗散与堆积看中西医的分析框架差异	49
VII 第七章 社会意义中的性别	51
16 生物学知识的文化性	51

第一章 总论

医学人类学的五大发展路径

生物医学人类学路径。生物人类学家的许多贡献有助于解释进化过程、人类基因变异以及人类有时易感有时抗病的不同方式之间的关系。比如节俭基因假说与镰状细胞贫血假说，总体上来说都是假说。假说而并非事实，需要注意。节俭基因学说认为，影响胰岛素生理机能的基因经过选择，使人们能够适应不规律的食物供应。这种适应性出现在某些人群的“盛宴或饥荒”时期，包括一些美洲原住民，远洋太平洋岛民和奴隶后裔的非裔美国人。然而，在现代饮食中，这些基因加重了慢性疾病的负担。这里强调该因素并非否认其作用，而是应当为嫁接有根据的解释方式的行为加以注意与警惕。

生态学路径，即生态医学人类学路径。在医学人类学中的生态学观点侧重于环境背景与人类健康之间的相互影响，其强调人类的整体环境包括大规模人类活动的产物以及其自然现象，健康收到人类生态学各个方面的影响。它包括关注人类在不同的环境中生存，如何寻找食物、如何分配资源、如何应对疾病以及人口结构、如何随着时间的推移而变化、导致传染病的病原体（如疟疾病原体，阿斯旺大坝的例子）和影响慢性病风险的因素（如饮食）都与人类与环境的关系密切相关。医学生态学被用来描述这类方法。文化生态学研究文化信仰和习俗如何塑造人类行为，如性行为 and 居住模式，进而改变宿主和病原体之间的生态关系，政治生态学研究人类群体的历史互动以及政治冲突、移民和全球资源不平等对疾病生态的影响。这种加入环境因素的方式更加科学，因为其很难落入生物决定论的窠臼。

民族医学路径。医学人类学的最初发展源于人类学对不同文化的治疗信仰与实践的兴趣（Weilin, 1978），这些与治疗有关的信仰和实践通常被称为民族医学，人类学研究方法研究民族医学的人类学方法不仅包括了解人们如何看待健康和疾病，还包括研究治疗实践的社会组织 (Fabrega, 1975)。核心在于如何**诊断**与如何**疗愈**两个环节，病因学-诊断学-疗愈学。目前对民族医学路径的研究与生物性的结合并没

有如西医（即现代医学）般重要。比如，蒙医最精华的位置是骨科医学，苗医专注于外伤治疗，而主流研究专注于研究其心灵与象征意义。这可能是预设了一个普适性的身体而文化性不变化的缘故，而在学界中经常被忽视。基于文化与生物性之间不可分离的特性，这些因素也不应当被忽视。民族医学路径在体系上大致有两个分类：①**个人主义体系**，将疾病解释为巫师或愤怒的灵魂对病人施加的超自然力量的结果；②**自然主义体系**，从自然力量的角度解释疾病，如西方生物医学中的病菌理论，以及中国、印度和地中海体系中多种形式的体质失衡。

疾痛叙事，或又称为文化解释的路径。使用这种方法的人类学家经常把疾病相关的痛苦——无论是由于疼痛、残疾还是意识到自己的死亡——作为分析的中心，他们尤其关注疾病的三个方面：①**叙事**。人们讲述的关于疾病的故事；②**体验**。人们感受、理解与和疾病共存的方式；③**意义**。人们理解疾病的方式，通常将他们的体验与更大的道德问题联系起来。经验性的方法通常探讨疾病与社会世界中的问题之间的联系。疾病学士尤其可以展示某种症状是如何因为影响了与他人的关系而被视为麻烦的。叙事还可以提供一个协商疾病意义的场所，尤其是在家庭成员、病人、治疗者等之间的社会空间。体验式方法最常用于探讨**主观性很强的疾病**，如慢性疼痛与精神疾病。这些内心体验可能难以分享或解释。一个很有趣的方向是叙事医疗——与疾痛叙事不同，它最终的目的是达成某种心理疗愈的作用，虽然二者都运用了可能需要深入访谈的方法，但二者在最终目标上有所不同。

生物医学文化批判的研究路径，也是本系列课程的重点。其主要手段是将生物医学作为一种民族医学知识和社会实践系统来研究。身心二元是生物医学的基本前提，设计各种生物技术在不同社会中的应用、对信仰或知识二分的理解，以及对公共卫生的政治经济批判。生物技术包含多个方面：西医的病例、病人的病史都是被忽视的生物技术。如病例系统的电子化，不同软件的形式固定，发挥的空间受限，给从医人员带来了很大的不适应现象。

医学人类学的四个共识

- ①从人类生物学和文化之间复杂多变的相互作用中最容易理解疾病和治疗；
- ②疾病受到文化、经济与政治的影响；
- ③人体和症状是通过文化过滤器来解释的；

④医学人类学的见解对改善人类社会的健康和医疗保健具有重要的现实意义。

生物文化主义 (Bioculturalism)

生物文化主义指的是在健康和疾病中生物和文化之间发生的重要互动，包括分娩疼痛、取卵手术、颞下颌关节功能障碍的疼痛管理与饮食的禁忌。

目前医学人类学的一些热门领域

- ①与健康、疾病相关的身份创建与主体性
- ②权威知识建立的作用和影响
- ③医疗保健消费主义
- ④医疗体系的多元化与融合主义
- ⑤本地和全球卫生的不平等

第二章 文化、文化能力与生物医学

移植器官非常紧缺，等待可用的移植器官需要等待很长时间。现在有将猪心移植到人身上的研究。对于犹太人或穆斯林，教义认为猪本身是肮脏的生物，那是否可以容忍这样的医学界限？作为人类学的研究问题不注意于二元问题本身，人类学注重于在如何的情况下，文化的影响下个人与集体会作出怎样的选择。

当我们谈及中国少数民族文化时，更容易联想到少数民族与自然的亲近性、特色的服装与服饰、能歌善舞的传统——这些都是刻板印象的来源，某种程度上也是文化偏见。为什么我们会在特定时期把某个文化圈层的某个文化代表取出，作为文化的代表？这表明文化一直在改变，唯一不变的是文化的变化。但当某些元素被选为文化的代表，有理由去追寻这些元素被当作文化本身的原因。所有的传统都是如此，做人类学研究时应该格外注重这一点。

人类学可以贡献什么？

第一，人类学的安身立命之本是民族志田野研究。Sherry Ortner 定义民族志为“试图通过自己作为一种认知工具来尽可能地理解另一种生活”（1995: 173）。民族志要求研究者关注和参与研究对象的日常生活，目的在于通过本土情景中的经验性数据，从而培育一种从“本土人的观点”出发理解师姐的态度。尽管民族志的发展早已超出了马林诺夫斯基时代对科学的精确性要求、通过 80 年代的表述性危机，当代人类学家不再以“他文化”的代言人自居，而是高度警惕研究本身的伦理性和权力相关性，不断增强政治意识和自我批判的程度。但是长期的参与式研究的模式和理念确是根深蒂固不容动摇的。正是这种长期的、敏感的、心态开放的田野实践，使得民族志研究不仅仅提供了一套研究方法，更提供了一种审视和认知世界的崭新途径。

第二，人类学强调对意义的追寻和本体概念中的分类系统。对本土概念的追寻和解读是人类学中另一个维度的重要时间，尤其是医学人类学对疾病的跨文化研究更是遵循了解释人类学的这一传统关注本土文化对疾病的描述。中医系统和日常系统中，就有很多本土的分类与概念。对于人类学家来讲，“任何医学语言包括生物医学和其他民族、民间医学的语言都绝不是对经验世界的简单影射。它也是丰富的文化语言，连接着现实的高度特殊化的版本和社会关系系统。当应用于医疗护理的实践，医学语言会将其明显的技术功能性和其深藏的道德关注相联系。”（Good 1994: 5）

第三，人类学研究重视对研究对象进行情境化的解释。这个传统可以追溯到最初人类学家对整体论（holism）的强调，他们认为一个社会和一个文化应该在一个整体中进行理解，考虑到亲属关系，政治，经济文化等社会生活的方方面面。当今的人类学家则更强调将自己的演技置于市场经济、历史和政治变化的复杂过程中去理解。整体论在这个意义上理解为情境化更为贴切。人类学中所主张的情境化主要是两个方面，第一方面，所有文化时间必须在它们的社会环境中去解释，文化不是也不应当是孤立的，而必须与更广泛的价值体系、社会期望相关联。因而，人类学者的研究任务之一即是将社会生活的诸多细节放在它们所嵌入的社会情境中理解彼此的关系，第二方面，人类学所指的情境化是本土生活和全球秩序之间的联系。

人类学的研究对象：文化

文化作为人类学的研究对象由来已久，文化是什么的争论直至今日。80 年代，文化作为一个 tricky 的对象产生了复杂的一系列危机，很多人类学家不知道是否应该保留文化这个概念。那么文化作为一个研究对象，是否存在？

文化 101

日常用语中，“文化”更多的和艺术文学概念联系在一起。但人类学领域中的概念更加宽泛，我们认为社会上任何一个人都是有“文化”的。

文化是人类社会所生产和分享的一切事物。文化是生活的方式和社会的蓝图，社会是由共享文化的一群人组成的。文化不是一种“事物”而是一个由事物构成的系统。

6.1.1 文化的定义

文化的第一个定义是英国人类学家爱德华·泰勒的定义。他认为文化或文明是一个**复杂的整体**，是人类作为社会成员获得的其他能力与习惯。**没有事物不是文化的。**

①文化不是一成不变的；它不是一个事物或一组事物，这是一个由人创造和维护的复杂意义体系。

②文化是一种共享的，经过协商的意义体系，人们通过这些意义体系来解释经验并产生行为。

③文化是习得的。

上海的文化是什么（毫无意义的研究课题）；XX 如何成为了上海文化的一部分（正确的课题方向）；上海的文化代表为何是石库门（正确的课题方向）。

6.1.2 文化的特点

①文化是意义的系统。该系统由各个部分组成，即人。

- ②文化在人与人之间共享与协商。
- ③文化由知识组成。
- ④文化修习的过程称为文化化（enculturation）
- ⑤在实践中（即在日常社交互动中），文化框定已有的体验，反之亦然。

生物医学中文化的重要性

医患之间的误解。文化会影响：

- ①患者和医生对健康状况和适当治疗的看法；

②使我们容易患病的行为以及促使我们寻求医治的原因。医学院有一门课，教会学生如何与病人共处、处理医患过程中的问题；解决方案变成了一种预设、技术而非将心比心地诉诸普遍道德。这门课程有几个关键的预设：①设置课程是为了规避风险，教会医生在从业过程中避免职业之风险；②把医患交流的问题预设成一种需要通过技术来解决的问题；③把所谓的沟通预设为语言技术，试图通过语言这单一的信道简化医生与患者之间的关系；④患者侧的刻板印象：医生是看病的，医生眼中没有人的家庭状况与实际情况，但是实际的情况不是这样；如果医生对患者说并没有什么大病，回去好好休息就行了，你是不是会觉得医生的诊治有问题？在临床上，医生对患者的解读并非普通人群所想的那样。；

③影响我们对症状的描述以及对治疗的依从性。现在有很多慢性疾病的老年人，在症状缓解后会自行停药，医生通常会非常生气；

④医者的照顾行为。临床上质疑医者的权威性是非常少见的，一般我们都被规训为如何去做一名好的患者——医生本身也会去有意无意地去寻找他们所认为的、能够契合他们想法、同时能够**共担风险**的那些“好”患者。并且有时医生对同性恋身份的患者，其照顾力度可能相较于其他大众而言较低；

- ⑤生物医学已从疾病为中心的方法转变为具有健康和福祉的概念。

当代健康问题下的潜在文化动态

- ①生活方式导致的死亡，比如工作与学业工作压力、服药、饮食不良、酗酒与吸烟；
- ②一些政策决定导致某些人群无法享受医疗服务；
- ③传染性疾病通过移民和生活方式的传播；
- ④制药公司和医师团体游说立法，以禁止公民使用外国的原研药品。

6.3.1 张雪峰去世事件

张雪峰老师作为一名高考填报志愿方面的网红老师，本人的言论本就非常有争议。前段时间，他因在公司健身时突发心源性猝死而去世——从现代社会的角度，种种经历感觉并非不可理解。

这个社会为何倾向于突然出现非常容易突然间崩溃的身体？张雪峰老师是在跑步锻炼时突发心源性骤停而去世的；在直播时有人谈及他嘴唇发紫的现象，他也曾反驳这样的言论。这很大程度上是与社会生活结构相匹配的，很多人为了能让自己的生活与工作、学习得以稳定，习惯于忍耐疲惫与经常性的睡眠不足。生活不允许空白、不允许放空与停止，这种行为是现代社会所不允许的。

为什么社会要求我们时刻处于一种非常忙碌的状态？包括现在非常多的直播博主，其劳动付出完全与其语言与各方面的表现所挂钩——这与老师上课的情景非常相似，实际上也是一种形式的表演。再者，张雪峰老师所处的行业处于一种全民情绪的焦点：通过他的知识储备与更大程度上的即时反应，所试图将一种混沌的信息状态转换为一种有序的方式，让他自己站在了社会信息洪流、社会阶层流动、家庭责任、平台经济与专业权威的投射与焦点。

这件事情之所能引起共鸣，这反映了这个社会的现状。“躺平”甚嚣尘上，但是没有被真正实施过，所有人似乎都被卷入了这样的死胡同里。为什么忙碌就变成了现代的生存与组织方式？没有特定的时间可供放空，人越来越难真正拥有一种自己所真正拥有的时间。未来导向的社会环境某种程度上是这种状态的根源，哪怕是休息时间都变成了所谓的工作（如跑步相关运动，尤其是马拉松运动的流行，都被视为助力更好的工作的准备，这类运动会强化人的独立认知，从而不愿意承认自我

的脆弱性）——也许我们可以选择承认脆弱、转而去重视当下与现在。

能否想象另一种生活方式？其实是有的，只是我们的知识限制了我们。目前我们所有被输入的知识都是围绕着生产性和高效性运转的，是否可以学习和自然相处的技能，复归到非市场经济生产的环境里？

生物医学在社会生活中的渗透

①通过强制机构对药物的处方权进行管理。中国有着悠久的自我诊断、自我用药的传统，这种情况在上世纪非常普遍，某种程度上造成了一定的耐药性泛滥问题。

②由医疗机构给新生儿开具生育证明，某种程度上也是对人口的管理手段；

③免疫接种和健康检查作为入院入校的前提；

④开假条、确认缺勤、获得补偿金；

⑤管理签发死亡证明书。

总而言之，人类学的共识现代生活的方方面面都离不开医疗，医疗成为了一种社会治理和社会控制的一种工具。人生所有的状态都在医疗中有所反映。

6.4.1 医疗的三大文化功能

①**提供解释**。负责提供含义和功效，同时涉及疾病体验的构建与组织。有一些长期的慢性病不被认可，在被医生确诊时，原因提供了某种程度上的重新组织。

②创建用于命名、分类和解释疾病的认知类别。

③进行康复。这里的康复不只是社会上的康复，更重要的是社会关系上的康复。

文化分析（不考）

需要进行全景式的方法。如果只是关注诊所和个体的故事，不关注医疗服务体系和社会环境，整体就变成了一个所谓的故事汇，在人类学上没有任何意义！

①微观方法，关注人与人之间的动态护理，发生在医生与患者之间的互动。

- ②宏观方法，研究医疗服务的方式是如何影响医疗服务的社会机构。
- ③所有医疗系统与产生它们的文化系统相对应。

6.5.1 文化分析的作用

文化分析对于理解生物医学的本质至关重要，即认识自己。跨文化的观点阐明了生物医学的本质，它只是有关健康治疗的众多只是来源之一，它提供的知识但并非唯一或完全正确。基督教认为人死去之后，人无法和 soul 进行交流；西方的葬礼没有物质性的接触，缅怀的是人生前的样子——这某种程度上塑造了现代医学；中国文化中的死亡发生在众人的加重，盛大的葬礼需要持续若干天，涉及了很多歌舞的成分，还有烧纸钱的习俗，把死亡后的灵魂看成可交流的个体。

文化分析有助于解释为什么其他种族道德实践仍然存在，即接纳“他者”。

讨论：巴勒斯坦的第一部动画《Fatenah》(2009)

由真实故事改编，巴勒斯坦的独立动画公司制作。以色列方面的一个医生团体想要呼吁人权，在众多示例报告中挑选了这个故事。Fatenah 在 2004 年死于乳腺癌。

到底是什么导致了 Fatenah 的死亡？你认为这之中除了乳腺癌，什么可以被认为属于文化的因素？

6.6.1 讨论

我们认为所有因素都与文化有着过多过少的关系；没有因素不是文化的。

①战争和政治、经济上的原因是重要的原因。医保和医疗基础设施的不完善在加沙地区已是常态（电影中提及在看病时公立医院停电），医生需要在众多医院中兼职，医疗体系和基础设施（全科医生、专科医生的配置）处于一种非常脆弱的状态。

②医疗保险的不到位。虽然覆盖了乳腺癌，但是实际情况比医保条目上的状况更慢。同一个医生在多个医院兼职，在公立医院的支付费用高于私立医院。

③乳腺癌手术后需要非常多的照顾，不仅是家人的照料，更是医疗系统的照料。边界的封锁、押金要求无法为 Fatenah 提供家人的支持，这也能算作政治的因素。

④安全因素、权力与性别问题。电影中很多空间都给 Fatenah 带来了心理上的压力，即使受到了合理的治疗，但是没有全方面的 recovery，Fatenah 也不可能康复。加沙地区的文化认为 Fatenah 前期的不适来源于没有结婚（在我国现实中也存在如此的现象与判断），民间的信仰与文化在如此一个父权的制度下对女性施于变形的理解。

需要注意到这个电影的叙事是被以色列方面的医生团队所主导的。导演与团体想要主张：①政治和政治团体的立场上，反战因素，在战争因素里促进人权；②**医生的立场上**，医疗健康作为一个最基本的人权，胰腺癌作为一种**性别特异的疾病**，一定要早发现早治疗、注意随诊与检测技术——这种话语是医疗与生物医学界的主流叙事，但需要指出，这种主张存在一定程度上的问题。

对所谓“文化”之批判

在人类学中处理文化是比较棘手的，但是实际行动上以大体表述和表征为主。但是很多其他学科还在继续使用 80S 之前的使用方法.....

文化是否存在

文化是人类学最不稳定的概念。20 世纪 90 年代，随着全球化的进行，对于文化的传统认知，即在一个特定的文化里每一个人都平等地参与到本土地社会经济体系的设置里，展示这一相同的行为模式并遵循共同的价值体系的观念受到了深刻的冲击。这本质上也伴随着欧美为中心的前殖民体系的瓦解，从而研究者无法拥有很好的研究便利；一些之前的人类学研究被认为是前殖民时期的遗留；很多人类学家到新几内亚研究当地文化，发现麦当劳已经开到那里了！

7.1.1 保护文化行动

网络论

医学人类学家 Marilyn Strathern 捍卫文化这个概念，认为它“提醒我们去关注，事物是如何在实践与技术的层面上被表述、被概念化的。人的价值判断建立在他们

对于世界的理解之上，反过来，观念也塑造着人们思考、回应与行动的方式……观念从来不是孤立起作用的，它总是在其他观念所构成的语境中运作；而这些语境会形成特定的语义场域，这些场域既使不同观念彼此关联，也同时将它们区分开来。”

以科学为导向的一些学科认为文化知识遵从自然科学的模式，去除了上下文的——贫困文化，那到底什么是贫困文化？研究一群人为什么是贫困是有意义的，但是贫困文化作为一种预设了人群属性的概念是不正确的。又及，有些其他学科把文化作为一种孤立的变量，这在人类学界也是被拒绝的行为，因为所有的概念都是建立在一个语义网络里，多者互相关联。

全球化-本地化张力论

Arjun Appadurai 则认为今天（90s）的主要问题是“文化同质化和文化异质化的张力”，文化同质化一般是指商品化和美国化，文化异质化是本土化的过程，当不同的思想、知识、行为、技术和物质被适当地转化从而适应新的文化视域，也就是新的本土性的获取过程。麦当劳不是中国文化或香港文化，它是一种 global 的文化。

值得注意的是，很多生物技术和医学技术的本地化都是西方舶来的，因此其值得研究 (!)。比如，B 超作为一种检查胎儿是否有结构性异常的工具，到了东亚、南亚与东南亚，B 超还用来检查选择性别工具；卵子冷冻技术进入中国之后，因为各种因素，单身女性就不再能冻卵，出现了很大程度上的地方性。

民族国家的文化

新概念：Mythohistory。民族国家经常自觉地借助一个独特的历史和文化概念，让人民意识到所谓“传统”价值的存在，这种传统价值作为一种道德教条被遵守 (Daniel Valentine)。

这本质上与被政治化的文化概念相关，也是殖民体系崩溃后的必然产物，民族国家有建立自己国民身份的需求，人类学界用动态的观念看待这个现象，并把它看作一个 history——文化都是锚定于一个历史阶段的。

一个典型的例子就是 TCM 的复兴（汉医，本质上是之前提到的代表性问题）。传统必然和现代医学是对立的么，有了现代医学才有传统？孝——国家通过孝道强调家庭在养老中的地位，实现分配责任、减轻国家行政负担的治理语言（但在社会主义社会中，国家承担养老责任）；清明节放假——在短短两代人间，成为了一个纪

念烈士的节日。

文化作为实验的工具

文化对于人类学家是一种“试验的工具”。它使得“利益，获取途径，需求，欲望与哲学视角的不同显现出来”。尤其是在生命科学领域中，当我们开始面对诸多有生物技术、信息数据，和生态互动的发展带来的伦理困境，人类学家必须发展不同的文化分析，来帮助进化的文明社会中所呈现的社会机制 (Michael Fisher)。

因此，文化概念必须保留——作为一种工具，它十分地好用。当一位学者言及其研究文化时，就意味着 ta 正在研究一个复杂的有上下文的网络。

所谓文化能力（这并非人类学的文化！非常重要！）

在西方医疗体系语境中，面对广泛的移民，为促进“族群文化敏感性”的医疗体制建立，经常提到的概念是“文化能力”。医生能否理解不同文化背景的病人所面临的问题？文化导致了差异性。

北美，英国很多地方的医疗职业者不断强调文化在医疗中的作用，和族群中的风俗、习惯以及行为模式。其目的是为了提高医疗服务的水准，实现以患者为中心的医疗关爱。

把文化视为一种需要克服的障碍，这个理念在后来出现了非常大的问题，即**文化的医疗化** (medicalization of culture)，本质上是“他者”的刻板印象强化。比如在生殖领域里，美国人对中国的生殖文化的印象是——“坐月子”，尤其是不能见风、冻着。但是在西医中，分娩需要用到冰块以促进子宫收缩，这与中国的生殖文化存在**表面冲突**；实际上是有可以协商的边界，但是他者化时就变成了一定程度上的刻板印象。

“为什么她如此拒绝使用冰袋？原来是文化造成的，我需要教育她一下，让她接受这个。”

这一系列的措施某种程度上导致了**文化主义**。预设文化和科学的理性相对立，包含大量的迷信和信仰，这些信仰是的特定的族群患者不接受不配合医疗手段。文化主义被权势的个人和机构所利用，将人民的视线从致病的社会、经济和政治因素上转移到所谓的文化问题。

很多国际组织和跨国行动中，就容易出现这些问题。在说“这是文化问题之前”，务必悬置文化和族群概念，细致了解后面的原因。

7.2.1 动人的故事和一个悲剧

安妮·法迪曼 (Anne Fadiman), *Spirit Catches You and You Fall Down: A Hmong Child, Her American Doctors and Collision Two Culture*(1997)。莉娅·李是 1982 年出生在加州默塞德市的老挝苗族移民的孩子。从三个月大时开始，她开始遭受惊厥性癫痫发作。美国医生将其诊断为癫痫病并接受了治疗，但她的家人认为癫痫是“灵魂损失”的证据，除了不规律地服用处方药之外，还让她接受了草药和苗族 Sam 祭司的治疗。在过去的几年中，经历了许多痛苦的危机，莉娅的医生与她的父母为抗击这种疾病付出了巨大的努力；家庭与医院经常彼此斗争。有一次，医生坚信父母无能为力或不愿意按照她的指示服用药物的行为正在伤害莉娅，因此对其父母发起的诉讼——这导致莉娅有一年被送到寄养家庭进行护理（在东亚家庭中很难接受），最后她的家人还是设法成功获得了监护权。

1986 年，莉娅的癫痫又一次发作，伴随败血症与休克，这使她昏昏欲睡，并且大脑严重损伤。这种状态下，她回到家中，收到了家人的细心照顾。她于 2012 年去世。

为什么苗族社群会如此看待癫痫疾病？

根本的冲突在于这个家族是一个贵族的 q 萨满世家；苗族的萨满被认为具有治愈的功能。只要不危及到个人的生命，尽量不用西医的方法。

正是两者都没错才导致了最终的悲剧。

八个重要的问题（也关于疾痛叙事）

- ①这是某个学名，但是你（或你的家庭）把它称为什么？
- ②你觉得是什么导致了这个问题？
- ③你觉得它是什么时候开始的？
- ④这个疾病对你有什么影响？
- ⑤这个疾病有多严重？它有一个短期或者长期的病程么？

⑥作为病人，你觉得自己应该接受怎样的预后措施？你最希望治疗之后收得的效果是？

⑦这个疾病带来的最主要的问题是？

⑧对于这个疾病，你印象最深刻的一件或几件事是？

Janelle S. Taylor 的评论

莉娅的故事是一场文化悲剧，或更准确地说，是一场独特的“文化”悲剧，因为正是莉娅父母和医生双方由于各自文化之间的差异而政治。因为双方都毫不妥协，因而碰撞的力量大大增强。

执着地追求自以为正确美好事物的行动会对于自己的错误视而不见。

所有的“文化能力”的提出或文化能力的药方是错误的，需要 Beyond “Add Culture and Stir”。文化不是一个静态的永恒的东西，而是不断变化的。因为人们总是以创造性的（有时令人惊讶的）方式利用着他们的文化资源。生物医学被认为是一种真正的知识、没有文化的文化，在这个环境中很难避免这个假设。需要解释的是生物医学的“替代品”：其他的物品，如误解、滥用，而非生物医学本身。

Taylor 不希望对文化能力的误解。相比于所谓的文化能力课程，她提倡：①学会将自己视为社区或更大社会的一员；②学会尽量与现有的不公平的排外社会、健康与经济结构进行对抗的意识。

医生的医学知识并不会因为它是真实的就少一些文化性。正如病人的生活经验与视角，也不会因为它们具有文化性，缺少一些在真实性。“文化”并不是摆在某个“外面”、可供书本去“谈论”的“东西”。它是一个生成意义、生成社会关系、并生成我们所栖居世界的过程；我们所有人都卷入其中——无论是在阅读与教学时，还是在诊断与治疗时，并不亚于我们在刺绣与献祭之时。

7.2.2 殡仪馆

一位印度人的母亲在心脏病突发的反复抢救后去世了，被从太平间运输到殡仪馆时，是裸身被送至地点的。在印度，已婚女性是不能不穿衣服的，那么这位印度人就要求将母亲生前的衣服同她一起火化。然而，衣服本身在手术抢救时就被剪开且无法再找回。印度人与医院开始了多方的协商。医院方面的跨文化专家告诉印度

人，这是你母亲的“业力”，试图让印度人从所谓的业报角度理解；再者，由于抢救进行了两次，衣服是在第一次抢救时被剪碎的，严格来说衣服本身并非是在死亡时穿着的衣服——专家试图说明这不是院方有意的问题，但是跨文化专家把“业报”脱离了佛教的语境进行解释，把关系性道德性、文化性的问题转移成了某种程度上技术化的问题。母亲的遗体在殡仪馆停放了两周也并未火化，这是由于一名印度宗教领袖高告诉他，其母亲的灵魂并未安息。

于是医院方面作出了他们所认为的让步，说可以把医院的标准流程进行标注，以适应不同文化的不同要求；并邀请印度人参加会议，把该条文视为其母亲所留下的宝贵遗产，并由此怀念其母亲的贡献。

.....？跨文化专家与院方认为的文化是一种纯粹的**标签**。

印度人的要求：①精神损失费；②不带任何附加要求的道歉；③在教堂举行一个特殊的仪式。

印度人要求的合理与不合理之处

为啥你不站在传统印度文化的立场呼吁印度文化的权利？

讨论 I

阅读 Gordon, Deborah. Tenacious Assumption in Western Medicine. 在自然主义与个人主义两种西方文化传统中讨论了生物医学。

7.3.1 在自然主义中重要的命题有哪几个，如何理解，在生物医学中的表现有哪些

命题 1，自然独立于超自然。自然界被视为一个遵循物理力学规律的机械系统，去除了宗教、神学或超自然色彩。真实性与物质性成正比，越是物理的、物质的，就越真实。**医学表现**：医学将疾病视为机制故障而非神谴或道德罪恶。健康和疾病被定义为如血压、生化指标的物质指标，而非精神或感觉状态。

命题 2，自然独立于主观经验。自然是客观给定的，独立于人类的目的、情感和主观经验。主观的意义不能用于解释自然。**医学表现**：医学严格区分客观的体征

与患者主观抱怨的症状。情绪被认为会干扰理智，甚至会导致功能性疾病，但不被认为是真正的器质性疾病。医学偏好于物理操作而不是去感受。

命题 3，原子主义。事物的本质存在于其本身，而非它与外部的联系中。整体只是各个部分的总和，部分可以从语境中被抽离出来而不改变其本质。**医学表现**：疾病被认为具有独立于宿主的实体身份；人体被划分为各个孤立的器官和系统来对待。健康与疾病被视为离散对立的实体。

命题 4，自然与文化分离。人类首先是生物学意义上的动物，文化只是一层表面的、外加的涂层。底层的生理是普遍的，表层的文化是多样的。**医学表现**：医学分类被认为是描述自然规律，而不是被文化所规定。文化因素在医学中通常被贬低为仅与患者的肤浅信念或行为有关，而生物学被认为是绝对普遍的。

命题 5，自然与道德分离。自然界对人类的善恶漠不关心。**医学表现**：疾病的发生被视为机制问题，不带道德评判。医生只负责诊断和治疗，而不去评判患者的善恶。但讽刺的是，随着医学发展，维持健康生活方式的道德责任正逐渐转移给个人。

命题 6，自然独立于社会。自然秩序和社会秩序互不干涉。客观真理独立于社会权力关系之外。**医学表现**：疾病被视为遵循自身法则，不论阶级贵贱。疾病本质上是一个个人问题，从而被系统性地从如贫困、权力不平等的社会经济背景中抽离出来。

命题 7，自然/真理是普遍的，独立于时间或空间。真理是永恒、绝对、单一的。西方偏向于抽象的法则或本质，而非具体的个体存在。**医学表现**：医学历史被看作不断逼近唯一客观真理的累积过程。医学基于假设的平均人来制定标准，医生总是倾向于将患者的独特事件归类于某种抽象的诊断标签中。人体被视为普遍的、非历史的、非社会的被动客体。

7.3.2 在个人主义中重要的命题有几个，如何理解

命题 1，主权个体、个体先于社会。个体是西方宇宙观的中心符号，拥有独特的、内在的、界限分明的自我。个体在逻辑上和价值上都优先于社会和文化。社会只是独立个体为了实现各自目标而签订契约的结合体。

命题 2，主体性的客体化。现代自我具有双重性，既是主体也是客体。个体能够将自己及自己的身体视为可以被观察、拉开距离、控制甚至拥有的财产。自我的

核心身份是固定和坚不可摧的，独立于其所拥有的特质或经历。

命题 3，社会作为派生物及自由的潜在敌人。既然社会是个人组成的，社会机制只是手段。同时，社会关系、他人和情感卷入往往被视为对个人自主权和自由的潜在威胁和消耗。

命题 4，作为道德代理人的抽离自我。西方道德体系建立在捍卫个人主权、确保平等、权利和不受干涉的自由之上，而非强调义务或社会连结。一个理想的道德主体能够从社会角色和情感中抽离出来，进行理性、普遍的抽象判断。当传统社会共享的宗教和道德价值观衰退后，医学接管了这一领域。用健康/疾病取代了善/恶，用精神疾病取代疯狂，用治疗取代了惩罚，医学成了彰显个人自主权和掌控自然的世俗宗教舞台。

7.3.3 讨论实录总结

一、症状与体征的区别。症状是患者主观描述的感受，例如疼痛、头晕、食欲下降，无法通过仪器直接检测，容易受情绪因素影响；体征是医生通过听诊、触诊、如血常规、电解质、B 超、血清检测实验室检查等客观手段观察到的指标，被视为疾病的金标准。医学更偏好体征，因为体征符合可测量、可量化的自然主义原则。对于无法测量的症状，医学会怀疑其掺杂了情绪成分。

二、自然主义医学观及其问题。西方生物医学深受自然主义影响，认为疾病应基于客观物理证据，排斥主观感受。症状因带有情绪因素，被认为不够可靠，可能干扰对真实体征的判断。这种观点导致患者主诉的疼痛、不适等有时被轻视，例如一个短视频段子中，丈夫陪产时喊痛，被医生称为幻痛并嘲笑，说明主观疼痛未被认真对待。但疼痛实际是真实存在的，如果麻药失效等医疗失误被忽略，医生可能误归因于患者体质或情绪。

三、安慰剂效应的反向运用。大医院在临床试验中常分两组：实验药组和安慰剂组。安慰剂效应利用了情绪和心理因素对病情的改善作用，这证明主观感受确实有治疗价值，尽管自然主义医学不重视它。

四、个体主义与社会的关系。个体主义强调个体应优于并超越社会，社会对个体自由构成限制和影响。在医学中，这体现为将个体孤立地视为治疗对象，忽视文化、社区、人际关系等社会因素。典型例子：张学良戒毒时把自己绑在床上，完全

依靠个人意志，拒绝他人帮助。这反映了个体将身体视为可被自我意志控制的对象，体现了身心二元论（灵肉二分），即自我本质上是意识，肉体是外在于自我的控制对象。

五、自然主义与个体主义的矛盾及道德化后果。医学接管了宗教和道德衰退的领域后，理性成为类似信仰的自身法则，自然主义变成普遍法则。按照自然主义，疾病本应是个人道德问题，自然秩序独立于社会秩序。但实践中，个体是否健康、是否锻炼、是否合理饮食被转化为个人道德责任。讽刺的结果是：经济条件好、有钱有闲的人更容易遵守医嘱、管理健康，从而被医生评价为“更好的患者”，拥有更高的道德；而贫困群体（如慢性病患者无法控制饮食作息）则被指责为缺乏自制力、不遵守医嘱，遭受道德谴责。**例子 1**：美国圈地运动后，印第安人被迫迁往狭小土地，饮食单一，加上大量开设麦当劳，导致代谢病高发。医学研究却归咎于他们生活习惯差，而根本原因是土地政策剥夺；**例子 2**：墨西哥因可口可乐工厂将淡水用于生产，使可乐比矿泉水还便宜，贫困人群只能喝可乐，导致超过三分之一的人患糖尿病和肥胖。这本质是社会因素，却被解释为个体选择、习惯问题。

自然主义和社会相分离，个体也与社会相分离。社会情境（如地域性经济问题）被忽视，普遍性的生物机制被强调，但导致疾病的社会原因却被转化成个体化的用语（如“你的选择”“你的习惯”）。医学伦理难以处理这种有前提的社会因素，导致不公平的道德评判。

7.3.4 补阙

①中国的传统思想告诉我们，扩展家庭或社会是个体存在的前提。我们环境下的个体不是脱离于社会关系存在的个体，这也从侧面体现了中医为什么会不同于西医。西方个体主义告诉我们，社会不是个体存在的前提，社会是个体存在的制约，自由的个体是伦理的基础、权利语言是西方个体主义的核心。

②在自然主义的传统里，身体越来越被视为一种重要的“对象”。个体的身体被认为自然界在个体身体上的表征，它有稳定的身份，与个体是分离的——“我”对“我”的身体有所有权，以皮肤为界，与他人相分离。作为一个对象，身体没有文化与情感，作为一个物而独立存在。

③理解个体主义的最好方式是思考原子论。最优先的是个体先于社会，不以社会的存在作为前提。医学的生命伦理强调所谓知情权，知情同意在现代医学中处于

非常重要的地位。它的背后即个人主义，个体的自主性与权利高于一切。在我们国家中，个人主义在一定程度上会变形为家庭主义，知情同意书某种程度上可能会有隐瞒并产生了不少医疗纠纷——所谓的知情同意不一定尊重家庭的意愿和核心利益，这是因为我国作为一个东方国家不具有个体主义的传统。

④总体来说，个体作为原子的存在是脱离于社会整体的。尽管多学科会诊和文化关怀尽管正在解决这一问题、西医的“加起来”方式是一个连字符式的文化符号，原因在于原子论观念的巨大顽固性。交叉后产生的知识和方法论可能需要全面修改，而非照搬照抄。

⑤在自然主义的认识论上来说，自然主义的知识作为自然的表征，同时知识总是去情境化的、普遍的、抽象的。自然主义的知识必须来源于理性个体；感官经验必须服从于理性；以及最重要的，获取知识的方式是很重要的：使用视觉获取的知识才是最客观的（腹腔镜、B 超、内窥镜），其他的都要尽量排斥。在所有感官中，最需要排斥的就是最主观的触觉。视觉是提升控制感与权威感的一个途径。

讨论 II

阅读 Good, Byron. 1994, How Medicine Constructs Its Objects.

7.4.1 作者认为对于医学院学生来讲，学习医学的过程是怎样的

作者认为，对于医学生而言，学习医学不仅仅是吸收新的认知知识，甚至也不仅仅是学习解决问题的新方法和新技能；它是一个进入并逐渐习惯栖居于一个新世界的过程。具体而言，这个过程包含以下几个核心特征：

①**进入一个特定的现实系统**。学生们发现，医学的世界充满了日常世界中根本不存在的客体（如分子层面的病理、精确解剖的组织）。学习医学意味着建立对这个独特生活世界的认知。②**重塑大脑与感知**。如书中的医学生受访者所言，这是一种强迫性的情感体验，需要直接与信息、死尸、体液甚至绝望的病人互动。学生们感觉到自己的大脑每天都在被以一种非常特定的方式重塑。③**掌握一种全新的外语和符号形式**。学习医学被比喻为学习一门外语，但这不仅是背诵庞大的词汇表，而是学习通过一套专门的形成性实践来介入现实并建构医学的现实。④**重构人的概念**。

在这个过程中，学生们学会了将日常生活中的人重构为医学凝视下的身体、病例、患者或尸体，这是成为一名合格医生的必经之路。

7.4.2 作者是通过医学院培养的哪些关键环节来理解医学院学生的现实世界的

看。解剖实验室是一个具有独特道德规范的隔离空间。在这里，学生学会把皮肤看作像橘子皮一样微不足道的部分，并透过现象看到人体内部三维的、层级分明的微观结构。学生被训练出一种解剖学思维，这种看的方式让自然的人体消退，一个由生化过程和组织病变组成的客观、物质的医学身体得以浮现。

写。当学生进入医院开始临床轮转时，写病历成了核心环节。作者指出，写病历不仅是记录对话，更是**建构患者**的过程。病历中标准化的分类决定了医生如何提问，并迫使学生将患者生动、混乱的个人痛苦故事编辑和纯化为符合病理逻辑的医疗项目。同时，这种书写也授权了医学生去对患者进行身体和精神上的干预。这个故事是在专业人士的圈子里流通的故事，同普遍意义上的故事有所区分。

说。病例汇报或诊断学（被临床学生戏称为医学表演学）是医学生面临的另一大考验。学生必须学会在查房时向带教医生讲述带有高度说服力的疾病故事。这个故事必须抛弃患者的个人生活背景和主观情绪，转而紧紧围绕疾病的起源、生理机制的演变以及鉴别诊断来展开。通过这种叙事，疾病被确立为医学实践的唯一合法客体，而患者的生活世界则被系统性地排除在外。

7.4.3 作者在这篇文章中的主要的理论对话对象是谁？她与该对象都有哪些分歧？

经验主义（包括生物医学的自我认知）认为，疾病是外在于文化的、纯粹物理和生理的客观实体；医学语言不过是一面自然的镜子，客观地反映了这些实体。作者借助哲学家恩斯特·卡西尔的符号形式理论对此进行了反驳。作者认为，生物学并不是脱离文化的，医学其实是通过其特定的日常实践（如上看、写、说）主动建构了疾病和身体，医学知识本身就是一种特定历史和文化下的符号形式，而不是对自然纯粹的客观临摹。

作者高度赞同**福柯**在《临床医学的诞生》中提出的观点，即医学凝视和话语实

践建构了医学的客体，医学是通过特定的知识实践来构造其认知对象的。然而，作者对福柯提出了极其敏锐的批评。福柯认为只有策略而没有战略家，只有意向性而没有主体。作者认为，福柯为了强调权力与话语，完全排除了实践、个人的主观体验和活生生的身体。对人类学家，这种忽视患者和医生的生命体验、交际互动与主观感受的做法是站不住脚的。

向**批判医学人类学的学者**对话。他们通常将临床医学贬低为一种掩盖阶级剥削、实施社会控制的工具，认为医学话语是一种虚假意识或神秘化，并将医患关系比作战争和纯粹的剥削。作者认为，如果将医学仅仅看作权力和剥削的工具，就无法解释为什么人们（包括人类学家自己）在生病时如此迫切地渴望得到良好的医疗照护。批判学派忽略了医学在现代社会中扮演的**救赎**功能：在现代西方社会，医学在很大程度上接管了传统宗教面对死亡、痛苦和有限性时的道德与救赎意义。医学实践不仅仅是权力的行使，它同时也融合了对人类苦难的深切关怀与道德反思。

7.4.4 讨论实录总结

一、**医学记录中的病人建构与内部语言**。病历书写并非客观事实的简单复现，而是经过医院内部系统层层加工后形成的合法化病人模型。住院医师、上级医生等通过特定术语和操作流程，将病人的实际状况转译为院内系统能够识别和认可的描述。这种书写具有内部流通性，如同一种外界无法完全解码的语言，其目的既是为诊疗提供依据，也是为了让病例在医疗体系内获得合法性。临床轮转经历表明，信息采集过程本身包含着有意识的院内操作导向。

二、**医学实践中的主体抽离与身心异化**。医学生在进入实验室或解剖室时，常经历一种自我感知的切换。例如生理学实验中处理活体兔子的血管时，操作者感到平日的恐惧被抽离，仿佛在特定环境下存在另一个我。解剖学接触大体老师时，部分学生虽受冲击，但最终通过将对象物化来消解不适。这种经验反映医学训练促使个体将身体客体化，形成一种临时的、抽离日常道德情感的专业自我，符合身心二元论的实践逻辑。

三、**医学世界的权力依附与人际网络**。中国医疗体系内，临床医生的晋升与生存高度依赖师门关系。存在类似师兄弟、小老板的准帮派结构。科室主任如同教主，其门下学生前途与导师地位紧密捆绑，一旦导师在内部斗争中落败，整个团队可能被迫离职。科研课题立项中，评委是导师师姐即可轻松通过的情况屡见不鲜，甚至

方向较水的叙事医学课题也能因人情关系获批。手术科室的师徒传承带有强烈学徒制色彩，决定权往往在于主任是否愿意收徒，外地医生为拜师需长期筹办饭局、召集人脉却未必如愿。这种人际运作不完全关乎医术科学，更像传统手工艺行会的权力生态。

四、**医学科学的操作弹性与量表数据的人为因素**。部分医生承认临床研究中的数据存在可操作空间，尤其是功能量表类的主观评估指标。有 36 岁即晋升博导的主任医师坦承数据都是可以编的，意指量表结果可在合理范围内按需调整。这虽非普遍现象，却揭示了在强调客观量化的自然主义医学框架下，主观判断依然以隐蔽方式渗透并影响所谓的金标准数据。

第三章 疾痛叙事

健康与疾病

健康的定义：世界卫生组织将健康定义为“不仅仅是没有疾病和羸弱，而是完整的身体、精神和社会福祉。”这种定义经常被认为太过宽泛，因此有人将健康分为体验性的健康与功能性的健康两类。

批判医学人类学家认为，健康是为了获得和控制基本的物质或者非物质资源，从而维持和促进生活质量的高满意度。事实上，健康是很难真正定义的，因为它体现的是一种理想状态下的文化价值判断，深深根植于文化隐喻中。

疾病

生物医学认为疾病是一种适应不良的状态，在生病期间，生物体至少暂时是与其所处的环境中的敌人进行一场失败的战斗。生物心理社会方法的创始人 George Engel 认为当适应或调整失败，预先存在的动态稳定状态被破坏，这时是疾病状态，直到新的平衡被恢复，再次与环境进行有效的互动。生物医学将疾病理解为一种不正常的状态，一种身体或精神的正常结构和功能的偏离。

8.1.1 疾病 (Disease) 与疾病 (illness) 的区别

一般认为**疾病**是通过各种身体迹象识别，通过医务人员诊断的。

疾病是通过解释活动或叙述才能确定的，根植于一种文化上构成的解释模式，试图澄清痛苦的来源，并勾勒出治疗者和病人所要追求的治疗过程。侧重于一种“解释的模式”所提供的体验。

疾病与疾病的分离不是凯博文的独创贡献，这最初是一位美国的儿科医生发现并主张的。

8.1.2 不同文化对疾病的理解

不同文化对于健康和疾病的定义都倾向反映其基本文化的核心主题，离不开当地的文化价值体系。

①加拿大詹姆斯湾克里族认为健康是个人与文化和自然之间的一种平衡的关系。健康意味着适当的狩猎行为，因此也意味着人类与土地上的动物建立的尊重关系，成功的狩猎意味着健康的饮食，适当的社会关系意味着狩猎的食物将在自己与自己的亲属之间进行分配。

②非洲西南部卡拉哈里沙漠的 Kung San 人将出汗的能力解释为健康的指标，因为汗水被认为是一种赋予生命的物质。

③秘鲁东南部亚马逊河上游雨林的 Matsigenka 人是一个由捕鱼、狩猎、采集和园艺组成的混合竞技群体，用 shinetagamtsi 这个词来指一种满足感，生产力、食品充足和远离疾病，这是一个与生产生活绑定的概念。

中国的汉族地区主要用“气色”来形容人的健康，不侧重强壮或其他方面，在于人与宇宙之间的平衡状态。

讨论

中国汉族地区传统上对疾病和健康的理解？

要理解健康与疾病，必须在社会和文化背景下进行研究；人们所知道的健康，总是与社会的其他关键主题和结构纠缠在一起。

治疗 (Cure)

8.2.1 安慰剂效应

任何治疗程序（或任何治疗程序的一个组成部分），①被故意给予以产生效果；②在不知情的情况下对症状、综合症、疾病或病人产生效果，但也被用作研究中的辅助对照。安慰剂效应被定义为安慰剂所产生的变化。这反映了治疗过程的仪式效应。注意，这里不是指安慰剂就是骗人的，这有依赖于特定的空间效应、仪式。从根因上来看，人类对疾病的反应分为三类：

①自主反应，即有机体为获得健康或平衡所能调用的所有过程，包括各种免疫系统和相关系统；

②身体对治疗的具体反应，无论是服用草药还是青霉素；

③意义反应，或在疾病治疗中意义的心理和生理影响。

安慰剂效应表明，病人对治疗的主观理解和反应，而不仅仅是治疗的客观生物影响，而且对病人的康复或恢复起着作用。

在普通的生物医学中有没有安慰剂效应？

当我们求助于现代医学中的医生，这一套制度性的安排。临床医生身着特殊的服饰，医院是特殊的场所。治疗的条件与场所对病人本身是具有意义的，在一定程度上能够产生真实的生物学效果。

疾痛个人传记 (The illness Autobiography)

是疾痛叙事的前身与雏形，集中于高级知识分子，拥有先天的发声渠道优势。共同的主题包括患病之谜（疾病的意外和难于确诊）；身体的背叛；与医疗人员与机构的冲突；医学上的无法治愈；对于自己的依赖等。被认为是最早的成熟疾痛个人传记是 Norman Cousins 的 *Anatomy of an Illness*(1979)，记载了作者患上强直性脊柱炎的经历，强调作为患者要用小对抗痛苦，强调情绪与创造力的治疗力量；揭示医学对技术的过度依赖。

—Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. Norman Cousins, *Anatomy of an Illness*(1979)

—The median isn't the message. Stephen Jay Gould, *The median isn't the message*(1998)

医学和统计机构的数据，统计学意义上的绝症还是有希望的。作为医生的 Oliver Sacks 的 *A Leg to Stand On*(1984) 讲述了他在阿尔卑斯山徒步时右腿韧带受伤被切断的经历，在伦敦就诊时希望强调自己的疼痛是身体所有感受的总和，作为一种全身性的经验存在。但他的观点不被医务人员所理解，被认为不是一个受临床医生欢迎的患者。作为患者，要学习的第一件事情是——be patient。蒽。他强调医学制度对病人主题感受的压制。

哥伦比亚大学文化人类学教授 Robert F. Murphy 的 *The Body Silent*(1987) 讲述了自己确诊脊髓瘤后逐渐瘫痪的经历。“身体已经沉默多年了：它没哟悲伤，也不愤怒，只是沉默。它不再是我的身体，而只是一个我需要搬动的东西。”作为一本人类学界讲述瘫痪经验的传记，深刻反思了身体与社会的关系。

上述这些都不是成熟的疾痛叙事。从上述作品思路和论题的发展可以看出，疾痛叙事的真正议题不仅与个人的经验相关，必须引起更多的思考，包含社会性与文化性。

人类学中的疾痛叙事

这是疾痛叙事的另外一支起源。列维-斯特劳斯的重要作品 *The Effectiveness of Symbols*(1963) 阐述了分娩过程中的治疗叙事，萨满巫师既不使用药物也不接触妇女，取而代之的是，他为患病的妇女提供了一种语言，通过这种语言，可以立即表达为表达的心理状态，并且诱导生理过程的释放。他不仅通过这个案例解释了叙事的力量，并且试图在本土治疗与西方医学（特别是心理治疗）之间找到接轨的可能性。

对于疾痛叙事的阐述方面，Good(1994) 指出，我们应当关注，这些叙事在多大程度上报道或描述了事件或经历的发生？..... 好的历史记录是否反映了事件和经验，还是选择了事件并进行了文化上的组织？社会生活本身在躲在程度上是一叙事方式组织的？

疾痛范围一般包括自闭症、颞下颌关节综合症，乳腺癌，抑郁症，糖尿病，艾滋病，精神疾病。最适合做疾痛叙事的疾病是慢性疾病与罕见病。

有关疾痛叙事的人类学研究中缺乏跨文化中的叙事；很多研究仍然是以西方和生物医药中的疾病为主的叙事。

8.4.1 疾痛叙事的理论流派与代表人物

理论视角	代表学者	关键观点
解释模型 (explanatory models)	Arthur Kleinman	疾病的理解是文化性的，医生应倾听病人叙述
治愈性叙事	Lévi-Strauss	叙事具象征性治疗作用，如库那莎满的故事
行动叙事	Cheryl Mattingly	病人通过叙事重建生活路径与原望，不只是回顾过去，更是生成未来
对话叙事	Elliot Mishler	医患沟通中的叙事是合作建构的，不是独白

凯博文《疾痛叙事》

凯博文强调，病人根据对他们和其他人有意义的事情来安排他们的疾病经历。这些个人叙事给予痛苦的遭遇以连贯性。但是病人并不讲述完全私人的故事；相反，他们从他们的文化遗产中汲取清洁线和隐喻，创造出对他们有意义的叙述，并向他人讲述他们的故事。疾病叙事表达了病人生活经验中最重要的东西。医学人类学的应用目标往往是阐释病人的经验，特别是在那些因为他们的声音被更强大的社会团体或阶层所忽视，因为历史、社会、文化或政治等因素而默默承受痛苦的人。

8.4.2 社会苦痛 (Social Suffering)

痛苦不是狭隘的个人经验，当今世界的许多痛苦与全球资本主义经济体系的变化密切相关。医学人类学家用社会苦痛这个概念将个体的痛苦与困扰的经验与更广阔的社会事件和结构性条件相结合，这往往是人类苦痛的最终来源。社会痛苦是指个人对政治和经济权利的残酷行使所造成的广泛的人类问题的切身体验，如强迫堕胎、强迫绝育、恐怖、政治强奸、剥削与赤贫。痛苦记忆包含文化的创伤：集体记忆中的创伤，有助于不同社会群体的身份建构，人类学的一个目标是在手机现代不平等和压迫历史的幸存者的叙述中发挥作用，作为“痛苦和生存的见证”。

8.4.3 早期对“叙事”的理解

Labov and Waleersky 的 *Narrative analysis: Oral Versions and Personal Experience*(1967) 阐述了两个观点。叙事是一个样受限制的言语类别，被面熟为叙事的语言必须描述过去某个时间发生是某种实际事件，并且在某种程度上是非凡的或非同寻常的，叙事是对现实的表征而不是构成。

叙事的社会用途

叙事可以围绕着什么是可接受的和不可接受的来设定道德界限，同时指出一个行动方案。在中国的语境里，叙事作为行动的源头而非忏悔和自我充实。受访者对人类学家说真实的人类学家所用的知识，对社会工作者说真实的社会工作者所用的知识。叙事可以增加听众的知识，用它来面对未来生活的挑战。叙事是一种文化机制，用它获得或宣扬特定的社会身份和自我理解。

8.4.4 疾痛叙事的改变与发展

只能通过叙事了解事件

在后现代主义的背景下，叙事性描述与叙事世界之间的分离被认为是非常成问题的，我们只能通过故事来了解事件，除其他叙述外，我们无法确定故事是否与实际事件相符，疾病的叙述是多声部的。比如一个患者经历了多年的背痛，在不同条件下的结果不同：临床医生认为从片子来看没有明显的结构性问题，建议保护性治疗并保持心理稳定，这属于事实，但否定了“有病”的事实。从患者的视角上来看，患者认为每次 ta 站起来时，那种“钉子扎进身体”的感觉让她无法忽视，侧重于经验性的真实——这种叙事建立了一种在情感上真实，但在医学上可能不被承认的医学事实。家庭上，家人没有非常好的方法，更多地处于一种不确定的状态：医生说没有结构性的问题，病人有时感受到困难，这则是一种处于不确定性上的叙事。

叙事的非凡之处是“解释”行动

叙事不是简单地“治病”或“让一切回到原样”，而是让人们在混乱中抓住某种意义，找到面对生活下去的动力。实际上，做事比讲述更重要。要求一个怀孕、坐月子、生孩的女性回归怀孕前的生活，这真的合理么？从实际的数据上来说，很多

生孩后的女性很难再回到怀孕之前的状态——叙事的有用之处可能更倾向于在一个废墟上的建立，而不是回到原来的某个状态。一个好故事的关键不是它发生了什么惊天动地的事情，而是讲故事的人**怎样理解它、赋予它意义**。尤其是医生或治疗者，如何通过语言把事件和病人的人生、情感串联起来。**切忌死套理论！**

在讲述疾痛叙事时，对受访者来说，议题总会自然地脱离身体。这侧重了对话叙事的重要性，在现象学的角度，采访者需要从受访者的片段中耐心地将这些片段联系起来并建立意义。

不是仅仅有关过去

故事不仅是在讲过去发生了什么，也在展望未来。讲故事是为了让愿望和选择而有方向，有意义地通向我们想要达到的人生状态或体验。患者讲的故事很可能包含目标导向。医生讲的故事则更关注未来，他们的时间观是基于流行病学的预测模式，就像是身体器官慢慢衰退，按照一定节奏出问题的生物时间。比如一个病症大概会在什么时候恶化、哪个器官会先出问题，这和病人正在经历的痛苦有所区别。

叙事不是单个作者而是联合作者

故事的情节并不是一开始就完整在那里等你去发现的，而是需要你一边听、一边读、一遍自己拼出来的，每走一步你才看到下一步会怎么样。情节是在理解和互动中慢慢形成的。

叙事并不提供解决问题的唯一方案

很多疾病的故事并没有一个清晰的“结局”或“答案”，因为讲述着自己也许孩子啊经历治疗的过程，孩子努力寻找希望。他们一边活着，一边在思考不同的可能结果：可能会好也可能不会好。

在临床医学上的疾痛叙事

症状是患者对于疾病的解释，疾痛叙事一直都被认为是临床医学的一部分。18世纪之前的医学完全依赖于疾痛叙事本身。技术的发展，比如 MRI 等的使用，是的医生可以获取人体内部的医学影像，从患者叙事转为了各种医学检测。

电子病例的发展是否会导致医生叙事的减弱？在多大程度上医生还可以输入一些非结构的评论？

在这种需求的推动下，叙事医疗兴起了。这和疾痛叙事的视野有区别，叙事医疗希望通过叙事达到一种治疗的效果，同时可以协助诊断疾病并进行医学教育，最大的场域是家庭。现代治疗师和后现代治疗师的不同在于，前者侧重于揭示秘密，后者侧重于共建意义。医学教育中对疾痛叙事的使用在于，更好理解患者的决策过程。

8.5.1 思考题

疾痛叙事很适合西方（强调忏悔）环境与女性（擅长共情与讲述）。如果在一个不是这样的文化和环境里，疾痛叙事可以成立么？在中国，特别喜欢“讲述”的大多是城市中产。但是对于边远山区的人们，他们的疾痛叙事该从什么方向进行？

Hint：西方的“语言中心主义”真的通用么？不是所有人都需要通过言语获得主体的。

讨论：记录电影《Unrest》，“无法安睡”

8.6.1 讨论

作为人类学研究者，在访谈深受某种疾病困扰的研究对象时，研究者不属于患者群体，那作为记录者的人类学研究者有何责任？这个问题可能没有非常好的回答，比较合理的是让受访者从最终形成的作品中获得 ta 们所想要获得的事物；通过将作品与患者共读，进行言语上的微调——这基于研究者与患者之间互动的基础之上。一些学者尽管通过呈现所谓猎奇故事或卖惨、贩卖奇观的方式获得了一定的益处，但是这些行为无疑没有负起相应的社会责任。

Unrest 是否尽到了疾痛叙事的社会责任呢？从四个方向可以明晰：①通过访问社区中发现、命名、推进 ME/CFS 的研究者，同时将 ME/CFS 的 NIH 经费情况与糖尿病、孤独症等常见疾病进行对比，呼吁社会关注疾病、基金委加大对其的研究与支持；②将该疾病的叙事放置于一个更大的社会和历史语境之中。这是因为精神性疾病在现代医学中是大幅边缘化的：精神性疾病由于不符合现代医学身心两分

的实证主义的预设，所以经常被误解与忽视。③为什么只有在丹麦可以进行关于 ME/CFS 的听证会？丹麦是一个高福利的、实行“北欧模式”的社会民主主义国家，这是某些政治上的因素；④从历史原因上看，由于 ME/CFS 的患病者中女性居多，且女性在社会中的医疗地位经常性地被污名化、轻视化，涉及到女性主义的社会议题。

第四章 疾痛的社会建构

总述：社会建构论

社会建构论在医学人类学语境中提出的必要性

社会建构针对的是疾病的生理性。社会建构强调是平时理解中“自然”现象的文化和历史性。社会建构强调疾病的意义和体验是由社会文化体系所塑造的，因为患者在讲述建构事物时采用的是文化的语调和符号形象。在 *Unrest* 中，导演采用的是实证主义的方式，试图为 ME/CFS 进行生理性归因。这与社会建构的理论相反。注意，切忌将所有叙述都归入社会建构。社会建构不是唯心的概念，强调社会建构不等于现实不存在。社会建构在某种程度上是一种比喻，强调的是一种“建构”的过程，社会建构的关键作用在于让我们知道现象是有历史的，不能拿来就用。社会建构不是某种理论，是一种引导研究者提出研究问题的框架。

疾病社会建构理论的三大主题

①疾病的文化意义；

②作为社会建构的疾痛体验。典型对象就是 ADHD；

③作为社会建构的医疗知识。最经典的是，知识通过研究而出。进行基础研究需要资金资助。观察某种医疗知识的流动与形成，在某些情况下。

9.2.1 疾病社会建构的理论根源

这源于美国儿童精神病学家 Leon Eisenberg 于 1977 年提出的 disease 和 illness 的两分概念。疾病是病痛的生理性，从医疗的角度进行诊断；疾痛是病痛的社会文化性，从患者、社会角度的体验和认知。为何批判的看得这种两分？这与当时的时代需求是紧密挂钩的，各种社会条件的制约与需求催生了这种理论。疾病与疾痛的区别、产生原因与 sex 和 gender 的区别、产生原因极其相似。

这里要补，疾病社会建构的理论根源与 sex/gender 理论的同源性与在当时社会上的革命性。

社会建构论的理论谱系

下面的理论流派让我们聚焦在社会互动，共同的文化传统与知识框架、权力关系的变化共同塑造着疾病。

9.3.1 理论谱系 I

1960-1970s 对于实证主义的批判（社会问题理论）。以往被认为是 deviant（异常）和 social problem（社会问题）的现象是在特定的社会历史情境下，被特定社会团体所制造的。

对于异常和社会问题的使用也是加强社会控制的手段。如“人口”，在社会建构论的角度不会说所谓青年人口不足、人口比例失衡、如何形成差异、如何解决；社会建构论会说，为什么人口会变成问题？人口是什么？人口为什么会变成一种科学？人口的概念是如何形成的？人口作为一种统治工具，是如何在我们的社会中出现？遵循社会建构论的路径，是想看哪些派系加入了概念相关的讨论；人口问题是随着统计学的发展而被提出的。当时有三组力量进行角力：掌握统计学新手段的人口学家；进行国防科学研究的专家；人文社科的相关学者。

9.3.2 理论谱系 II

1960s 象征性的互动主义 (symbolic interactionism) 和现象学的重叠交错。Erving Goffman 和其他象征性互动主义学者，作为患者的社会经历，因为和生物医学的定义相对，而积极开展一种所谓“道德职业”，个人通过持续的社交与互动而积极地参与自身社会世界的建构，包括自我的建构。现象学原则：展示人们如何看待自己的病情，如何应对身体和社会的局限并克服自我侵蚀。个体面对疾痛，并不是完全被动也非完全主观的，而是在这种互动中完成属于自己的社会实践。

9.3.3 理论谱系 III

Eliot Freidson 强调，不止应当强调社会建构中的患者，也应当关注医生角色。当医生将一个人的状态诊断为疾病时，医生也成为了某种程度上文化意义的赋予者。医生的诊疗本质上是一种社会活动、是一种被添加到生理状态的中的社会状态——这可以改变一个人对自己生活状态的认同，医生创造了疾病 (illness)，诊断本身是一个创造意义的行为。

Freidson 明确指出疾病标签的真实性和实质的社会后果。他认为社会学家应该特别注意“体征 (signs)/症状 (symptoms)”如何被作为疾病贴上标签，成为一种疾病。疾病是一种评估性的社会类别，是基于社会中对“理想的”和“不可接受的”观念而产生的。Freidson 的理论为之后对于医学分类和医疗知识的社会学研究奠定了基础。

9.3.4 理论谱系 IV

福柯的权力 (Power) 和知识 (Knowledge)。这与 18 世纪临床医学相关。强调对医学知识的审视，知识是权力的一种。强调专家权力中有关对于正常/不正常的建构，是一种现代社会的特有权力运行模式。现在的社会形式越来越趋向于一种所谓的“专家控制型”社会，即专家通过某些知识对社会进行控制，权力的流动在此产生——我们不再依赖于所谓的法律，而是依赖于规范——规范无处不在，医生是规范最常见、影响力最大的规范存在。所以福柯的理论对分析现代社会很有作用。福柯的传统强调医学话语 (medical discourse) 对于身体的建构，对人们行为的影响，对人们具身化主题体验的影响；医学话语同样塑造了人们的身份，并使得医学发明

取得合法的地位。福柯传统的研究对医学话语进行详尽的分析从而揭示它的恨意, 规范化的趋向于身份认同的联系。nomal→ 正常化、规范。这是现代权力运行的普遍模式。

社会建构的主要发现

9.4.1 疾病的文化意义

Susan Songtag 指出癌症的负面的寓意。在日常生活中, 艾滋病、进食障碍等疾病也有类似的负面寓意。

污名化的疾病

污名化的疾病 (stigmatized illness)。精神疾病, 癫痫, 癌症, AIDS, 阿尔兹海默症, 性病。研究表明在癫痫这个例子中, 很多患者都觉得相对于污名化, 其实抽出的症状还是很容易进行管理的; 在 AIDS 中污名化会限制患者进行治疗的途径, 影响社会关系。疾病本身的生理性并不足以让其污名化, 社会对这些症状的反应和揭示本身是使其污名化的原因 (如麻风病)。

9.4.2 疾病体验的社会建构

特别收到象征性互动主义和现象学的影响, 认为现实不仅存在于世界中, 等待被发现, 而是由个人创造出来的, 这些个体在所处的世界中行动着。

人们对自己的疾病付诸于行动并赋予意义, 在这个过程中患者不仅仅是一个被动的实体。研究者发现患者在患者角色上花费的时间是非常少的, 因此研究者**应该关注他们的日常生活**, 他们是如何与疾病共存的生活。这种互动性非常重要。

研究强调的是“局内人”的观念, 如何重塑“自我”, 重新审视以前的生活, 创造新的疾病身份甚至加入社会运动, 对自己的疾病进行知识的构造。

9.4.3 医学知识的社会建构

揭示医学知识如何反映和再现当下现存的社会不平等，医学知识不是价值中立，而是增强了当权者的利益。性别理论是一种有效的分析工具，医学将社会性别的理论铭刻于女性身体和心理上的话语和实践，进而增强了社会原有的性别不平等。

研究也揭示医学知识是如何以其发展的社会环境为条件的。也就是医学知识和社会知识之间的转化，相互印证。比如 Epstein(2007) 的研究分析了 1980 年中期出现的一种新的生物医学研究范式。

医学化（medicalization）发生在当人的问题或者体验被定义为医学问题，成了疾病与症状的时候。医学化的研究通常关注过程，一些特定的医学诊断如何发展，被接受与进行治疗的，如从“治疗”到“改进（bodily enhancement）”，从“医疗专业”到“技术消费”。

伟哥起初用于治疗老年男性和前列腺癌男性的勃起问题，但是现在被普遍当做传统的壮阳药..... 之所以其能够推广，主要还是因为辉瑞公司的推广策略（雇佣很多职业运动员，宣传“都能用”）。

9.4.4 社会建构论的社会影响

对于污名化的疾病、有争议的疾病、对于残障设施的完善，理解不同群体的争论；对于不遵医嘱的理解。促进了叙事医学的产生、自我的赋权、外行知识的重要性。增强政策制定过程的意识，比如如何定义某种问题决定了解决问题的途径。

9.4.5 社会建构论带来的转变

传统医学观	社会建构视角
疾病是生物异常	疾病的意义由文化/制度建构
医生为知识中心	病人经验也构成知识
不遵医嘱是”问题”	不遵医嘱可能是文化／资源／信任问题
政策解决” 技术性问题”	问题本身的定义也是一种权力

9.4.6 未来的研究方向？

网络对人们疾病体验的影响（更加公共化）；社会医疗化。

第五章 医疗化

医疗化与现代化

医疗化概念的提出

Irving Zola 认为医学已经成为社会控制的重要机制，替代了传统的法律和宗教。我们的日常生活各个方面都要维持“健康”，从而逐渐走向医疗化，属于一种社会控制的手段。

医疗化的历史

17 世纪开始，欧洲和北美的现代化孕育了一种“工程心态”，其表现之一是通过科学的应用来加强对变化无常的自然界的控制的一致努力。

18 世纪开始。国家支持医学作为一种职业得以稳固，作为工业资本主义和技术生产为中心的现代化的一部分，和日常生活中的官僚化与理性化相联系。

18-19 世纪，面临医学职业关注的扩张：①对于不同生活阶段的管理；②通过理性应用科学实现标准化管理，医学被纳入更为广泛的网络，其功能是规范整个人口的健康与道德行为。

日常生活中的种种行为都被规范化（normalize），比如情绪、性都成为医疗技术的管理目标。生殖活动进入公共卫生领域，母乳喂养、个人卫生都成为医疗的监视对象。一段时间内，我国母乳喂养率不是很高，这是因为剖腹产率高、而且部分人认为母乳没有奶粉有营养。母乳喂养的价值判断给女性带来了很多的道德和价值负担。医学在想要主张母乳喂养时，会拿出很多可信的置信数据——经过规范性的

问题（必然会将其中一些事情被划分为所谓规范的，同时还会将一些其他事情划分为所谓不规范的），最后终于养成了并且母乳喂养的习惯。

人们最害怕被视为“不正常”的人。

同时通过公共卫生的倡议和流行媒体这些途径日常生活的方方面面都被医学渗透。精神病人和许多居住在贫民窟的人群也被置于“panopticism”的位置。

医疗化的历史

10.3.1 人体解剖为基础的病理学的确立，取代了以往的体液-环境学说

人体解剖为基础的病理科学的确立推崇一个普世的规范化的正常身体，生病变成了一种失范的状态。

①引入尸检，使得病理科学更加系统化；②身体检查和案例搜索的常规化；③国家发明“人口”的概念（收集数据用于所谓的统计学手段，有统计数据才能将正常的与不正常的标准科学化），作为监控社会健康的一个平台；④公共卫生的产生，卫生组织直接支持国家机器，其主要功能是对人口进行监控。

因此引进医疗化的过程是现代化与标准化过程的一个体现，医疗化的前提是一个现代化的社会，需要使用标准化的科学技术才能实现。中医与民族医学不算作传统的医疗化。

10.3.2 分化的实践

19 世纪末，**分化的实践** (dividing) 把疾病与健康、疾病与犯罪、疯狂与理智等区别开来。

听诊器是 19 世纪初的重点嘎嘎猛，使得评估身体内部环境成为一种可能，将患者的主观不适感降为科学的“真实”的从属地位。

医疗化逐渐将社会的问题定位在个体的身体里，方案转向治愈个人的不适而转向福利制度、教育、贫困等结构性问题。医疗化随着现代化与殖民主义在全球扩散，作为帝国主义的一种工具而存在并与殖民体系相连，成为了**医疗帝国主义**。

推荐阅读：杨念群《再造病人》。

医疗化的批判

所谓批判不意味着反对。

社会学家与人类学家批判的是医疗化背后的“生物决定论”的幽灵。幽灵的原因是人们没有解决这个问题而把它匆匆掩盖。

医疗化在很大程度上赋予医生道德化评判的权利，医疗化疾病去社会化、去政治化是社会学家与人类学家所担心的。

10.4.1 Ivan Illich, *Medical Nemesis*(1976)

生物医学会引起医源性的疾病与伤害。抗生素滥用；空鼻症。

女权主义的批判

医疗是一个父权机构。女性身体成为与分娩和生殖生命周期有关的技术干预场所。助产士被强制性专业化、系统化并置于政府和医学界的权威知识之下的方式；对医学化的积极抵抗导致了家庭出生运动的兴起以及替代疗法和多种疗法的广泛使用。

医学人类学家作品也展示出不同阶层和文化背景的女性对于身体和生殖、技术的不同理解和实践，从而在某些程度上动摇了医疗化。Anne-Martin 认为要注意不同医生和临床的不同存在，关注女性在这些场域中自发的能动性。

医疗化的新变化

如何理解越来越多城市中产阶级呈现出的渴望医疗干预现象？

对月经不规律的焦虑在青年女性中蔓延，人们通常对特定的数值尤其焦虑，生活围绕着医疗化的数值所展开。中国的城市中产在这一心态上正在与美国城市中产趋同。

医疗化的身份、状况与健康

被医疗化的身份 (Medical Identity)

医疗化的过程也是身份认同和主体性产生的过程。美国一个社会学家研究精神疾病，当时美国的精神病院取代监狱，成为了一种管制行为不恰当的病人的机构，一些社会学家努力去除精神疾病的机构化。这位社会学家研究这些精神病人在精神病院中的经历，就假装自己是精神病人并被关进了精神病院（有一定的伦理争议）。研究期间，医护人员将他的任何举动（访谈、笔记）视为其精神疾病的表现，而那些不认为研究者是精神病人的人反而是那些被认定是精神病人的人们。

精神病学家 Robert Barret 对 Schizophrenia 的研究。幻听、幻视在临床上被视作非常重要的指标和标准。Barret 认为西方学界对人格的理解是建立在稳定的独立自我指涉这一基础上的（这某种程度上源于美国自己的文化因素，而亚洲的部分文化认为这并非为某种精神分裂或疾病的现象，尽管不被视为正常的现象，但有时并不需要一定的治疗；这些国家和文化的评判标准可能是多人格或幻觉导致的行动/秩序破坏），因此在临床诊断上西方就容易将其诊断为所谓的精神分裂。

被医疗化的状况与现象

日本的厌学逃学问题；

中国慢性疼痛的叙述（凯博文在湘雅医院关于神经衰弱的研究，1991）。主要发现是很多中国人把精神疾病身体化了（精神疾病被视为资本主义的产物）以获取自身的合法性——神经衰弱。凯博文意图将个体的痛苦与社会的因素相结合分析问题。

南非儿童的心理后遗症。南非的大规模种族隔离政策给儿童带来了很普遍的心理问题，当局用“心理后遗症”称呼这种病症，将社会和国家的因素转移到了个人的身体与病痛情况之上。

作为社会科学的学生，应当警惕将政治和社会压制转变为个人病态的现象，并通过医疗进行干预这种管理的规范化。这里不是说一定要全盘反对医疗化，在很多社会中医疗化是解决一些社会问题的较少出口，但是不能逃避其缺陷与灰色地带。

健康的医疗化

在中产阶级中，健康成为了一种普遍的“美德”。很多人使用健康 APP；你的运动圆环没有闭合；我们自觉自愿地将自己的身体交给了所谓的医疗化。

与思想和社会相分离的个体身体，根据生物医学中阐述的标准进行管理，这种活动成为自我表达的一种形式。身体美学成为某些人的目标。大多数人担心患病风险。通过对健康承担个人责任，个体表现出对自治的渴望，通过这种方式积极合作以成为“正常”的健康公民，从而确认主导的道德秩序。这种治理方法转化的好处在于，权力持有方通过转嫁矛盾让个人注意个体身体，反而忽略了社会关系的存在与影响，这从根本上降低了权力的治理成本。

健康美德的观念使我们忽视了社会不平等和各种歧视对健康的影响。个体对健康的责任使得政府尽可能减少了对公民的健康投资。

风险作为个人治理的手段

作为技术和流行病学上的“风险”是一种现代性的建构。对于健康人的所谓风险管理，要引起格外的警惕。所谓防范于未然的风险管理使所有人成为了被控制和管理对象，越来越多人成为等待中的患者。

道德中立的风险提供了一种手段。可以让专家们远离对人们生活的干预，通过“风险管理”，使人们调用自己的主观能动性，进行自我管理。在预防的基础上对统计学上预测的疾病进行医疗化本身就是一种应对风险的商业行为，比如越来越常规化使用的遗传学诊断。

我们目前正在见证与晚期现代性或后现代性相关的新“生物医学化”，一场涉及分子化、遗传化、数字化、计算机化与全球化的技术科学革命正在发生，而这些变化又与医疗企业相关的组织（包括大量研究的私有化）、专业知识和实践的完全转变相关。

在这种环境下，身体越来越有可能成为控制和改造的场所，这种控制和改造是以个人权利或愿望的名义进行的（签署知情同意书）。这些正在发生中的变化往往使得医疗公司获利，经常符合当打社会的功利主义利益，其首要目标是节省医疗开

支。

12.1.1 基因化

部分基因检测的经销商是美容院、理发等机构。预期的管理不限于医疗机构，也扩散到了正常人群。随着基因检测的成本降低和推广范围变大，分子遗传学和群体遗传学技术的结合，使得目前的医疗化呈指数级增长，这就是我们所称的“**基因化**”。

基因化是一种更加深入和强化的医疗化现象，随着对胎儿、新生儿和成人基因检测与筛查的日益制度化，监控的可能性就是无限的。在基因决定论的支持下，基因越来越被认为是一种“准病原体”，使我们在一系列疾病中的风险增加，比如产前基因检测中，家庭作出的很多决策是基于概率的推算。

衰老的生物医疗化 (Sharon Kaufman)

这块不考，仅作了解即可。

在医学人类学中，从医疗化角度研究衰老的主要就是 Kaufman 的作品。代表作：《Ordinary Medicine》；《生死有时：美国医院如何形塑死亡》。

一旦可以使用大量的医学干预手段来延长生命的想法这一思想被构建、表达并且提供给社会，它就必然成为社会伦理景观中的正常部分。个人、箭头和社会义务的范围被永远改变了。我们需要对干预措施本身的正确性、必要性和不可避免性进行社会科学的审查。

作为社会科学家的任务是描述在向老年人提供医疗服务过程中所发生的各种变化，并分析这些变化是如何影响关于老年知识、临床干预措施的期望，以及个人的经历 (Kaufman, 2004)。

12.2.1 有关衰老理解的变化

衰老的可逆性；干预导致更多的干预；对年龄本身的风险考虑正在降低。对于正常的适当死亡年龄的理解正在增大。与衰老相关的**新伦理领域**出现了。越来越多的人不在家中去世，而是在医院、急诊室、ICU 中去世。

三个特点：

①临床医学为病人、未来的病人、他们的家人与医生提供的关于是否和何时使用延长生命的程序，以及是否和何时停止这些程序的所谓选择，其实根本就不是真正的选择。相反，选择权被隐藏在常规治疗中。

②护理和关爱的性质已经改变，因此护理（包括医疗和家庭）、感情和价值的表达与临床行为明确地结合在一起，要么延长晚年的生命，要么允许放手。

③作为治疗选择的干预措施引起了对治愈、恢复、提高生活质量的希望和期待。反过来，在追求生命最大化的过程中，医学对治愈、增强与延长生命的关注界限也越来越模糊。

12.2.2 对医疗干预说不的可能性

几乎是不可能的，选择被掩藏在了常规治疗中。

当技术在老年群体被试用并证明有效，就变为常规，临床医生和病人越来越期待技术的使用。当技术变得不具有侵入性与较低的死亡风险时，对技术的需求之道德压力会增大。

在临床上对这些干预技术的实际选择被取消了，以程式为导向的医疗服务导致了病人、家庭和医疗人员对治疗干预说“不”几乎成为了不可能。

12.2.3 未来的照护？

生物医学技术提供了最强大的逻辑和最普遍的方法以体现我们的关爱。在医疗框架之外，在权利和义务的修辞之外，现实对最年长一代的关怀与爱是否可能？如果像 Rose(2001) 和其他人所建议的那样，身体已经成为对生命进行伦理判断的最重要场所之一。那么当一个年老的身体可以明确地从医疗干预中受益时，还有什么其他的框架是可能的？身体和医疗之外，是否还有其他方法来证明价值与爱？

研究医疗化的思路

将医疗化简单理解为强制性监控手段，或者仅仅强调疾病的社会建构而不承认个体的真实的疾痛和需求医疗帮助的现实都是不全面的。医疗化并非铁板一块，各种状态、条件如何被置于医疗化之下才是社科学生需要展现的，越好的研究越是复杂的。

我们应该关注政治经济的、技术所采用的形式，嵌入生物学话语和实践中的价值，以及有关身体、健康和疾病的流行知识。询问我们生孩子的各种状态和条件是如何被置于医学的范畴中，才能够更好地展示医疗化的复杂性。

讨论：药瘾《Take Your Pills》

安非他命是一种常见的兴奋剂，有效成分是苯丙胺；加了一个甲基就是冰毒。在中国类似的药物是专注达（盐酸哌甲酯），但药理上有所区别。

有时我们忽略了这些技术在早期发展中与军方力量的关联，安非他命在早期给二战中的德军飞行员服用，使其处于高度专注与兴奋的状态，使其专注注意力。

13.1.1 结合医疗化的概念，谈谈对药物问题的看法

我们可能不需要同意或者反对这种药物的有效与否，如果纪录片能够引起人们对医疗化现状的一些思考，那么纪录片就达到了它的价值。一些在机器和互联网时代被认为是障碍的东西，作为人的一些感受可能才是作为人的更珍贵的事物。

13.1.2 影片中美国社会中被医疗化的是？

注意力被医疗化了，为什么在美国社会中它会被医疗化？要把注意力变成一个疾病，这就对应特定的文化社会情境。医疗社会化在这里也变成了一个转嫁社会问题的媒介。

13.1.3 现实生活中被医疗化的例子；新的疾病和新的不正常

有人分享了自己 gay 朋友的司美格鲁肽焦虑，而且包含 Rush 和 Prep 两种药物的名称罔替、对追求所谓性快感与所谓预防艾滋之类的……按下不表。

生长激素、冰箱、骨龄等与标准身高相关的事情被视为一种普遍性的身高管理。

13.1.4 不同社会阶层的医疗化经历是否相同？

能够开到安非他定的基本没有工薪阶层；使用冰毒的是美国文化里的底层与无家可归人员，最终成为无所事事的瘾君子。毒瘾和所谓的个人意志力没有完全的决定性关系，这种现象中还包含着一定的结构性问题。

只是一个甲基的区别，专注剂和毒品就完全没有关联么？为什么不考虑其他的因素？

第六章 身体，与不同医学传统中的身体

总论

为什么要研究身体

①我们在社会科学领域里演技身体，是因为身体和我们对自己的理解（性别，种族，族群等）有着非常密切的联系。对身体的研究必然涉及社会性和文化性，这突破了普遍意义上生物学的范围；

②身体在我们和外部世界之间起着桥梁和中介的作用，这里的外部世界不仅仅是物理的，也包含着文化的环境；

③社会和文化规则总是深深地印刻在我们身上，塑造着个体对自身和社会关系之间的理解。这也是部分意义上现代女权主义的来源。广播体操作为一种贯穿学生阶段的一种体育仪式，向学生灌输了集体主义与整齐划一的初步理解。与西方相反，

中国的体育课程很少涉及体育的基础理论——中国体育教育的身体属于集体，必须和集体一致；西方体育教育的身体属于部分和个人。

14.1.1 日常生活中，什么时候会意识到自己有一个身体？

AI 本身就是一种去身体化的设计，认为人类最高的宝藏是人类的思维与思想，这些东西才是人类的永恒部分。

生病时对身体的感受是最敏锐的，思想想要控制身体的某个部位但受到阻碍时，我们会感受到身体的存在。青春期发育时也会感受到身体的存在，意识到身体不是那么的自然与性别的差异。染发和纹身、打洞的现象在编制与公务员序列一般认为是不恰当的行为。现在也有一些工作坊让我们意识到身体的重要性，试图恢复身体的感知。

另一点是家庭的、社会的各种规训能够非常明显地体现在身体之上。所以我们需要研究身体，因为它既是文化的，也是生物的。研究身体也就成为了一个明显的身体的框架。

三个身体的理论流派：生物的身体、生物政治的身体、社会的身体。

14.1.2 中国的体育身体

Brown 作为北京大学的留学生，研究中国体育制度对中国人身体的影响。她认为可以从身体姿态看出一个人是否是中国人：在进食西餐时，尽管能够非常熟练地使用刀叉，但中国人倾向于前倾着身形进食；西方文化的人则习惯挺胸进食。这映射了文化社会的传统规训与结构性的规则。

社会科学中关于身体的三个共识

①身体不仅仅是自然给予的，不言而喻的实体，因为在文化的控制范围内是没有什么所谓“自然”存在的；②在跨文化的语境下，身体各个方面的含义是不同的；③身体是进行社会控制的场所（福柯思想的一派，所谓身体政治，研究机构的理论）。

身体的不同文化解释

①中国传统文化将身体理解为宇宙的缩影，与宇宙的运动紧密联系。②印度在传统上任务身体-自我是在社会互动中物质和符号是可以互相身体的，表现为所谓的种姓制度。③美国印第安人的一支（纳瓦霍人）认为身体和外部世界自然景观是完美整合的。

中国有关身体的三个传统知识体系

①中医，有关针灸、中草药和气功；②宗教，主要是道教中炼丹、养生运动与长生不老的实践；③武术与功夫。

从中西文化看身体之谜

（日）栗山茂久，《身体的语言》

15.2.1 从两个脉的区别看中西医对触觉的定义

两千年之前，脉搏占据这中国和西方医学的核心地位。希腊医学主要是希波拉底文集和盖伦的作品，在盖伦的作品中有近 1000 多页的文字讲脉搏。希腊人把血脉想象成管道，血液在其中流动从而使得动脉扩张或收缩，从而在手指上产生压力成为脉搏，有节奏地运动着。

在中国最早提及脉的文字是马王堆手稿，最初也是指血管，汉朝的《黄帝内经》与《难经》都有记载。

英文的脉搏（pulse）：结构和功能（运动）的两分反映；心脏与血管；重视动脉朝向体表的垂直起落。与希腊思想不同，“脉”既可以指代血管也可以指代脉搏；栗山茂久认为这是翻译的权宜之计。自从难经以来，中国中医在美国手腕上是被出六个切脉部位：三个漂浮的和三个下沉的部分，但是这些脉行点并未用于检测通过血管的血液脉动，他们只是感觉到皮肤下有水流，可以用来诊断人体的十二个器官。

中文的脉 (mo): 强调脉位的重要性; 切脉要追踪影响身体疼痛的变化; 像山川、河流, 是流动的。

感受和认知是相互依赖的; 理论性的前概念不但影响了触觉的感受, 也受到了触觉的影响。我们在研究古人对人体的观念, 不但是在研究他们的思想结构, 也是研究他们的感官认知。田野对于社会学来说, 本质上是通过身体参与到现实生活中。

15.2.2 从解剖学与肌肉看中西医对视觉的定义

滑寿《十四经发挥》(1341)——“养生人”

维萨里《人体结构七卷》(1543)——“肌肉人”

(养生人) 与 (肌肉人) 的身体呈现两种状态: 前者比较灵活灵动, 强调柔韧性的身体——作为重要的部位 (丹田), 实际上本质是所谓“生命之气”的承载物; 后者强调肌肉, 精确的骨骼与肌肉结构。希腊艺术家很早就对肌肉/凸起的波状物开始进行描绘。整个西方艺术史中, 肌肉都是重要的概念与艺术主题, 而在中华文化中则没有该种传统。

有学者主张肌肉在古希腊文化中的重要地位是一种视觉至上的审美冲动; 还有学者认为这来源于古希腊文化对解剖的兴趣。

希腊医学中的“看”: 解剖学

中国也有尸体解剖。《汉书·王莽传》: “翟义党王孙庆捕得, 莽使太医、尚方与巧屠共刳剥之, 量度五脏, 以竹筵导其脉, 知所终始, 云可以治病。”这里主要是为了羞辱造反的党人; 宋仁宗庆历年间 (1041-1048), 广西地方官府处死欧希范等五十六名反叛者, 宜州推官吴简与医生和画工较仔细地观察了这些尸体的内脏器官, 并由画工宋景描绘成《欧希范五脏图》。这些举动看似是所谓中医的“解剖学”, 核心根源是为了认知中国的人体“宇宙”是与外界的大“宇宙”联系起来的; 政策问题上, 本质上是为了统一的政治语言服务。

早期的解剖学研究和对“自然的计划”的信仰, 解剖学家渴望看到但是超越身体部位形体的“目的”, 大自然是剧透先见之明的工匠。亚里士多德在《论动物部分》中写到, “看到血肉、骨头, 以及其他构成人体的器官组织, 不可能不觉得恶

心。”在古希腊，解剖学本身是为了知道身体的“内部”是如何运行的——一种穿透性的意愿；另一方面不是“机器化”的概念、不是用物理学的基础认知身体，而是希望通过人体内部的结构，希望与信仰自然与神的规划与计划（栗山茂久老师的“目的论”，身体构造体现神圣目的，每个器官的结构必然服务于某种功能，背后是造物主的智慧设计）。

器官组成身体的理论到了希波克拉底之后才成熟。盖伦认为“器官是动物身上的一部分，是指其为一个完整行动的源头，例如眼睛对视觉而言，舌头对语言而言，双腿对行走。”只要是工具，就是具有特殊用途的器具，预设了一个**使用者**的存在。现代的机械论务实了历史上的这个论点。

“一切器官的用处都与灵魂有关，因为身体是灵魂的工具，所以动物彼此不同是由于他们拥有不同的灵魂，有些动物较为勇猛，有些较为胆小，有些野性强，有些温顺……”他们每一种的身体都适应期灵魂之特质与能力。”要以解剖学的眼光看待身体，就必须把每个部位都视为具有特定目的的结构。器官的概念加强了行动与解剖学的关系。

灵魂与有机的身体相联直至 17 世纪，物理医学派开始用机械的观点来分析身体的运作。

希腊艺术作品中的“肌肉”

希腊艺术作品中没有肌肉的概念，相对而言有**良好的分节**（anthroi）。好的关节是判定一个人状态的关键，关节不明显代表不成熟。Anthroi 基于身体特定形状的分隔和区别，高度分节的身体是人为的结果，经过极端激烈的锻炼而产生，惧怕的是软弱。这某种程度上体现了**种族和性别歧视**的成分，亚洲人被所谓“分节不足”，体现了所谓的欧洲中心主义；男性的发展是 30 天（火热、干燥）；女性的发展是 42 天（潮湿、寒冷）。人体艺术“肌肉发达”提个背后的伦理学和美学规范中心概念是“articulation”。

肌肉

肌肉在希波克拉底时期很少有人提及，主要是骨头、肌腱与皮肉；希波克拉底认为心脏属于肌肉，但是当时的概念尚且模糊。盖伦时期提及 460 次之多，认为心脏本身不是肌肉，不受自我意志控制。到该时代，肌肉被视为一种器官，作为“受

主观意志控制而运动的器官”发挥这走路、说话等独特功能。盖伦《论肌肉运动》开拓了解剖学的结构视野，看到的是肉体与自我的关联。

这时的肌肉不代表神或自然的意志，而是代表肉体与自我的关联。肌肉使我们自己成为真正的操控者。这本质上是不灭灵魂的核心生物到自主性操控者的改变。

中国的自我认知不是“我是谁”，而是在于与他人的关系、位置。个体并不重要；在家庭、社会中的位置最重要。因此中医不可能发挥出所谓的肌肉概念，只能基于关系和位置进行解释。

身体的形式表达了一种创造性的设计目的，希腊运动员的健身训练和运动的人体艺术都是最好的见证；这种世界观强调主动和被动的区别。脉搏是被动的，而肌肉是主动的。从这里，我们不难看出身心分离的整体趋势。

希腊人开始致力于确定统治身体的原则，寻找身体的控制者（controller）。他们最终专注于大脑，器官是由灵魂操纵的工具，具有特定用途，灵魂操纵身体，尸体是没有灵魂的。中国人的身体则更像一个动态的系统，没有哪一个器官能够统治其他器官。中文的脏腑不是控制来源的工具，它们更像是储存气的仓库。尸体是没有“气”的身体，对于医生来说，研究尸体没有任何价值。

中医中的身体

中国的器官是非解剖、生理学或病理学意义的，着重讨论它们在生病或健康时会有什么现象而非它们是什么。这不建立在解剖学基础上，也不作为灵魂的工具。

中医中的身体没有主导的器官，权力循环：心主肺，肾主心，脾主肾，肝主脾。心脏虽为“君主之官”但是心脏不是一个人心理状态的主宰者，果决有胆囊主导；谋虑有肝脏主导，机巧来自肾脏，五味来自脾脏。“主”以不同的方式将各个部位串联起来，肺主皮，脾主肉，肝主筋，肾主骨。所以脾脏功能不好会瘦弱，肺受伤会皮肤粗糙。中国汉代医生看到的是色泽沉深的意义。

小结

肌肉认知的兴起，和一种特殊的 personhood 概念的出现密不可分，也就是匠人的概念和自主意识联系在一起；我们在追溯肌肉概念时也同时在追溯自主意志的形成。

15.2.3 从耗散与堆积看中西医的分析框架差异

对自主性的定义不同：①中国“满实”来自于避免生命力因外流而损耗，抗拒经历与时间的流逝；肌肉人像的自主性则来自于自主行动的能力，以及有意志独立制造，不受自然或机运影响的变化。

这里只是方便课程教授，进行了简单的概括。在实际研究时务必不要将所谓中国与西方的文化全然区分开来。

希腊放血术和病理

希腊人会让血液从身体的不同部位流出来，与中医有一点相似之处。他们认为过多的血液不利于健康，后来西方医学一直保留着放血的疗法。盖伦认为“一切疾病的内在原因都有两种解释，若非血液过剩就是消化不良。”血液过剩，身体就不再是意志能够轻易指挥的工具。对放血术的重视本质上是希腊人对于血液过剩的恐惧。

对放血的偏好主要源于对淤积的恐惧。盖伦认为放血不仅能疏解过多血液，而且能有效预防过剩血液出现。毛孔是人体排泄体内废物的渠道，所以出汗有利于身体健康。认为经血以及流鼻血都有预防的效果，意志这类出血会导致严重的伤害。

中国养生与病理

中国有关虚实的观点：实是满，健康的；虚是耗竭、疾病。因为中国害怕消散，喜爱囤积，更注重“补”血，补气。过多丧失精气是不好的。邪气只侵入虚空的身体，活力旺盛的身体不可能有空隙让不良的影响力侵入。毛孔是疾病可能进入体内的开口，出汗会让人变得虚弱——“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死（庄子）”。毛孔是疾病可能进入体内的开口，出汗会让人变得虚弱。

修炼、养生（中国）：通过对身体的修行达到对精神的提炼。比如各种现代生活中的养生活动。

不同的恐惧

希腊医学恐惧腐败和囤积，古代中医惧怕耗竭与流失。盖伦认为月经非常重要，是女性特有的男性活跃生活方式的自然代替品；常做粗重工作的女性，分娩比较顺

利，没有过多的“残余物”。中医不认为月经未排放是一种危险的压抑，而是血液耗竭的征象，必定是之前曾有耗损的血液。针对同样的现象，不同的文化有着不同的解释。整体而言，两个医学传统对于人类脆弱性的看法奠基与完全相反的恐惧：希腊认为要拥有健康，先劳动；劳动谁身体强健的必要，需要促进排泄与防止过剩；中国的养生之道提倡元气的聚集，强调刺激流动，形成柔软的身体，自我完满与灵活柔软是其目标。

对性行为的不同看法

盖伦认为女性若缺乏性行为，则会造成女性精华的囤积，导致比压抑月经来潮更严重的伤害，如窒息；男性则会感到头脑沉重，恶心，发烧，胃口不佳。中医则担心精液流失和性行为过度，而非欠缺，因为生命是有限的资源，可以有智慧地保存而绵延多年；精子是生命精华，每流失一滴都会造成生命力的减少。

中医中的“风”

风在中医中本身就是一种疾病，一些有自身耗竭的人更易收到所谓“风”的侵扰（因此中国没有产生细菌学说的土壤）。但是并非所有的“风”都会让人得病——所谓违反规律的存在，就被认为是所谓“风”。春东风，夏南风，秋西风，冬北风。如果某一天刮起不与季候对应的风，古代先民则把它称为所谓“邪风”，人吹了所谓“邪风”则容易生病；中医关心“风”，是由于宏观的宇宙秩序能够反映在微观的身体之中。把身体本身视为一种自给自足的实体。这反映了汉代宇宙论与身体论的模糊不清之处，为掌握这些变化，中医理论将其放置于阴阳五行与八方四时的规律之中——但悖论的是，越希望将其归纳于一个理想化的框架之下、越去寻求某种秩序，加强秩序的行动本身反而加强了人们对不可认知的变化的规则认知。这种对混乱的惧怕引发了对外界环境的最终自我隔离，促进人们自我修身养性以抵抗外部的混乱。

现在的科普读物喜爱强调所谓的刻板印象，反映了很多有矛盾的故事可以做。

第七章 社会意义中的性别

生物性别 (Sex) 与社会性别 (Gender)。生物性别主要是染色体、性器官与荷尔蒙的不同；社会性别是文化环境所决定的 (Lancet)。用这种二分化的看法看待 Gender 带来了很大便利但也有一定的 bias。一些性别研究学家大谈性别研究，但是把 Sex 交给生物学家，认为其是绝对客观的——实际上，完全两分的 Sex 在自然的状态下也是不存在的；生物学上不是完全“男性”与完全“女性”的例子非常多。

既不是男性的性器官，也不是女性的性器官——处于中间的状态非常频繁。在公众的平台中这些人的存在很少被认知。

所谓不同存在于“大脑”，认为男性擅长于空间推理、逻辑计算；女性擅长于情感、艺术与文学。这样的观念深入人心，容易影响实际的研究设计和跨学科表现。

生物学知识的文化性

Nature's Body: Gender in the making of Modern Science, Londa Schiebinger, Department of History, Stanford University.

“上帝创造了自然，林奈给了它秩序。”为什么分类如此重要？分类是干嘛的？分类本质上是建立一种全新的秩序。所有现代科学知识的产生一定是有分类的，没有分类就是不行的。

林奈创造的哺乳动物这个分类。为什么用雌性动物的乳房来命名？是因为其更朴实、更科学么？这是因为他要解决一个问题：如何把人放在自然的体系中去。林奈的《自然系统命名法》第一版沿用了亚里士多德的分类方法，把人列入到四足动物类之中；第十版改版后，他把人类放入了“哺乳动物”这一类别之中。这个分类方法被采用不是因为上述的任何一个原因，只是因为林奈需要完美解决他的问题。

文化的蓄水池给了林奈很多可说服力的素材。乳房在西方文化中的意义：繁衍、生育力；巫婆与处女；女性一直是被认为是更加接近自然，哺乳是人和动物的连接。男性代表所谓智人，他的理性特征标志了任何动物的分离。林奈的预设就很大程度上受到了文化的影响。再者，林奈生活在 18 世纪的欧洲，有很多社会问题需要解

决；18 世纪，乳母的风俗非常流行，自然学家们不由自主地将婴幼儿的高死亡率的解决方法与乳母的流行所挂钩。因此，林奈倡导母乳喂养；男性则起到在生产时陪产、监督的责任和义务。

政治日程：女性的社会位置在哪儿？女性在公共领域的形象，恰当的位置是成为一个忠于职守的母亲。科学知识不是价值无涉的，而是产生于复杂的文化模具内。

若许 Lysis 制作